



陶老师护士护师主管



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

# 500 考点

陶老师精选预测精华考点

## 2026陶老师考前预测

➕ 带你提高 **20-30分** ➕

适用于主管护师、初级护师、护士资格

2026  
最新版



- ✓ 重要考点 · 紧扣考试大纲
- ✓ 巧记记忆 · 高效快速提分
- ✓ 涵盖考点 · 高效复习首选
- ✓ 应用商店搜索陶老师APP  
免费做【30万】道护理题

陶绍华 编

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
点击右下角微信联系陶老师

## 2026 年陶老师主管初级护资 500 考点 考前最后一搏预测【25】小时=199 元

1. 一点都没有学的：只刷题的，停止刷题，听课还有希望
2. 没有完全学明白的：刷了很多题了，停止刷题，听课还有希望
3. 学的一般的：边学边刷题的 直接听课补缺补漏
4. 学的很好的：也刷了很多题了，停止刷题，补缺补漏锦上添花



可以让你提高 20-30 分的网课 可以让你提分的巧记

主管初级护资【考前 500 考点视频】时间安排：

1. 内外妇儿+人文 500 考点预测 【23】 小时（提供电子版讲义）
  2. 中医基础知识讲解 【2】 小时（提供视频）
- （4 月 1-4 号更新完毕，1 号中午 12 点 30 分更新，一直看到考试结束）

### 版权声明

本课程已向国家版权局申请版权

本课程未经授权不得以任何形式分享、共享、转载、转卖给任何第三方。  
第三方指除了学生本人之外的任何人，包括你的至爱亲朋、手足兄弟。

已和专业律师事务所深度合作，由专人进行市场监督。

本公司近期累计起诉 8 起盗版案例，全部胜诉。

特此声明，违者一定追究法律责任

## 2025 年主管护师陶老师 500 考点提分反馈

买了陶老师的五百考点，考过了

主管成功上岸，陶老师👍

陶老师

考过了

用你的 500 考点考过了

太高兴了

## 2025 年初级护师陶老师 500 考点提分反馈

2025年度卫生专业技术资格考试

|      |            |
|------|------------|
| 姓名   | 刘          |
| 报考专业 | 护理学(师)     |
| 成绩   | 基础知识: 78   |
|      | 相关专业知识: 77 |
|      | 专业知识: 80   |
|      | 专业实践能力: 67 |

刘一口 @微信

非常感谢陶老师

我一开始没怎么学 到最后买了500考点 500考点真的非常好 不用死记硬背 知识点都能记得住 真的非常感谢陶老师

扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2025 年陶老师执业护士 500 考点提分反馈

成绩查询

2025年护士执业资格考试

|             |           |
|-------------|-----------|
| 姓名          | 邓         |
| 成绩<br>(标准分) | 专业实务: 327 |
|             | 实践能力: 330 |

校验码: a16690bf f7c46e2f5f3

过瘾过瘾

昨天 20:34

恭喜恭喜 考了多少呀

昨天 20:44

买的陶老师的500考点冲刺了一周

## 2026 陶老师 500 考点预测 (1-5) ---慢性心力衰竭的病因及诱因

|                                                      |        |                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 病因                                                   | 心肌损害   | 冠心病 <b>心肌梗塞最常见</b> 、肥厚性心肌病、糖尿病心肌病   |                                                                      |
|                                                      | 心脏负荷过重 | 后负荷（心脏收缩时受到的阻力- <b>压力负荷↑</b> ）      | 左心室压力负荷过重常见于： <b>高血压、主动脉瓣狭窄</b><br>右心室压力负荷过重常见于： <b>肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄</b> |
|                                                      |        | 前负荷（收缩前的血容量→ <b>容量负荷↑</b> ）         | <b>四个瓣膜关闭不全，房间隔缺损、室间隔缺损，动脉导管未闭、甲亢、贫血</b>                             |
| 发病机制                                                 |        | <b>心衰主要机制→心室重构</b> ，从而导致心脏收缩/舒张功能障碍 |                                                                      |
| 诱因                                                   | 感染     | <b>特别是呼吸道感染是最常见，最重要的诱因</b>          |                                                                      |
|                                                      | 心律失常   | <b>心房颤动是诱发心力衰竭的重要因素</b>             |                                                                      |
| <b>【陶老师巧记】</b>                                       |        |                                     |                                                                      |
| <b>前负荷病因：</b> 1、潘金莲关（关闭不全）心（先天性心脏病）前夫（前负荷）评（贫血）价（甲亢） |        |                                     |                                                                      |
| <b>后负荷病因：</b> 2、后夫（后负荷）提（体循环、高血压）刀宰（狭窄）肥（肺动脉高压）羊     |        |                                     |                                                                      |
| <b>诱因：</b> 感染，呼吸道感染是最常见，最重要的诱因。                      |        |                                     |                                                                      |

**高效记忆：**潘金莲太性感诱发了这样的丑剧——诱因——感染

## 2026 陶老师 500 考点预测（6-10）——左、右心功能不全临床表现

|                                             | 左心衰（肺循环淤血）                                                                                                                                             | 右心衰（体循环淤血）                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要表现                                        | <b>主要表现：肺循环淤血</b><br>最早：出现劳力性呼吸困难<br><b>【陶老师巧记】</b> 我来得老早了<br>典型：夜间阵发性呼吸困难<br><b>【陶老师巧记】</b> 做了噩梦后夜间点灯深呼吸<br>晚期：端坐呼吸 严重者：急性肺水肿<br><b>【陶老师巧记】</b> 端着碗吃饭 | <b>主要表现：体循环淤血</b><br>最早出现的体征→颈静脉充盈<br>诊断右心衰最可靠的体征→肝颈静脉回流征阳性（最特异性）<br>早期在身体的下垂部位，出现凹陷性水肿，平卧位时最多见的水肿部位是骶尾部<br><b>【陶老师巧记】</b> 你又（右）肿么啦？ |
| 咳嗽咯血                                        | 慢性：白色浆液性泡沫状痰为其特点<br>急性：咳粉红色泡沫痰                                                                                                                         | 不明显                                                                                                                                  |
| 体征                                          | 特征性表现：舒张期早期奔马律→强烈提示心衰（看到这个就选慢性心衰）<br>交替脉（左心衰竭的特征性体征）<br><b>【陶老师巧记】</b> 坐在奔跑的马上脚踢大吼一声骂<br>奔跑的马上：奔马律 脚踢：交替脉                                              | 表现：只要是体循环淤血→<br>颈静脉充盈/肝颈静脉回流征阳性+肝肿大+水肿/胸腹水                                                                                           |
| 心脏                                          | 左室扩大为主                                                                                                                                                 | 右房右室大                                                                                                                                |
| 左肺——呼吸困难：左心衰导致肺淤血——气促 右体——水肿：右心衰导致体循环淤血——水肿 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |

| 交替脉                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 奇脉                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 左心衰表现<br>脉律正常而脉搏强弱交替出现的一种病理现象，以坐位时明显                                                                                                                                                                                                                                                                   | 右心衰表现<br>呼吸的时候有脉搏，吸气的时候无脉搏                                 |
| 坐（左）在奔跑的马上脚踢（交替）马背                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>【陶老师巧记】</b> 忽悠一呼一有 呼气的时候有脉搏<br><b>【陶老师巧记】</b> 右-回-奇-口对口 |
| <b>【陶老师巧记】——重点记忆左、右心衰知识点</b><br>左心衰【症状】：最早——劳力性呼吸困难 <b>【陶老师巧记：我来得老早了】</b><br>最典型——夜间阵发性呼吸困难 <b>【陶老师巧记：做了梦后夜间点灯深呼吸】</b><br>最严重——肺水肿、端坐呼吸 <b>【陶老师巧记：端着碗吃饭】</b><br>左心衰【体征】：最典型——交替脉 <b>【陶老师巧记：坐在奔跑的马上脚踢大吼一声骂】</b><br>右心衰【症状】：最早——恶心呕吐，双下肢水肿 <b>【陶老师巧记：你又（右）肿么啦？】</b><br>右心衰【体征】：最早——颈静脉充盈 最特异性——肝颈静脉回流征阳性 |                                                            |

## 2026 陶老师 500 考点预测（11-14）——心功能分级

| 分级   | 临床表现                                   |
|------|----------------------------------------|
| I 级  | 体力活动不受限制（ <b>陶老师巧记：</b> 一口气走上 6 楼，不费劲） |
| II 级 | 体力活动轻度受限制，日常活动可引起气急、心悸                 |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
点击右下角微信联系陶老师

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                          | (陶老师巧记: 分两次走上 6 楼, 中途需要休息)                                      |
| III级                     | 体力活动明显受限制, 稍事活动即引起气急、心悸, 有轻度脏器淤血体征<br>(陶老师巧记: 只能在 1 楼, 根本不能爬楼梯) |
| IV级                      | 体力活动重度受限制, 休息状态下也气急、心悸, 有重度脏器淤血体征<br>(陶老师巧记: 躺床上都累得不行了)         |
| 【陶老师巧记】一无二轻三明显, 四级不动也困难。 |                                                                 |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (15-17) ---心功能不全治疗原则

【陶老师巧记】强心利尿扩血管; 首先选择抗感染; 抗感染有抗生素, 抗生素首选青霉素

|        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病因     | 控制高血压、积极控制感染等首先控制感染                                                                                                                                                                                                                                 |
| 减轻心脏负担 | 休息 限制体力活动, 避免精神紧张, 减轻心脏负荷, 最基本治疗方法                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 饮食 给予高蛋白、高维生素、易消化、清淡饮食。少量多餐, 避免过饱; 限制水、钠摄入, 以防体液过多, 钠摄入<2g/d                                                                                                                                                                                        |
|        | 吸氧 给予持续氧气吸入, 流量 2~4L/min, 增加血氧饱和度, 改善呼吸困难                                                                                                                                                                                                           |
|        | 利尿剂 慢性心衰治疗首选利尿剂 (首选, 改善症状最快)<br>排出体内滞留体液→前负荷↓→心功能改善<br>①排钾利尿剂: 氢氯噻嗪、呋塞米: 痛风患者和高血糖患者禁用<br>(因其可引起高尿酸血症和高血糖)。不良反应: 低钾<br>【陶老师巧记】鼻塞不通风, 排自己脑袋, 急的我血糖飙升<br>②保钾利尿剂: 如螺内酯、氨苯蝶啶, 利尿弱, 常与排钾利尿剂合用, 加强利尿, 减少排钾; 高钾禁用<br>【陶老师巧记】早上躲在海螺的家内保护自己安全舒服 利尿剂用药最佳时间: 早上 |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (18) ---洋地黄禁忌症

洋地黄使用禁忌症巧记: 急死的肥鱼不能吃

急: 急性心肌梗死 死: 房室传导阻滞 肥: 肥厚梗阻型心肌病 鱼: 预激综合征

## 2026 陶老师 500 考点预测 (19-23) ---洋地黄中毒表现

|                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 毒性反应                                                                    | ①胃肠症状——厌食是最早表现 (也是洋地黄中毒最早表现)<br>陶老师记忆: 所有的中毒都是恶心、呕吐胃肠道反应          |
|                                                                         | ②心律失常——室早二联律最多见 ST 段鱼钩样改变、房室传导阻滞、心率下降——使用洋地黄前要数脉搏; 成年人<60; 婴幼儿<80 |
|                                                                         | ③神经系统症状——视物模糊、黄视、绿视、头痛                                            |
| 陶老师巧记:                                                                  |                                                                   |
| 洋——懒羊羊—羊角弯曲的像鱼钩样—心电图 ST 段鱼钩样改变<br>懒羊羊两个角——室性期前收缩二联律<br>懒羊羊一个字懒—慢—心率减慢阻滞 |                                                                   |
| 地——吃坏肚子了, 吐的一地——胃肠道反应                                                   |                                                                   |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

黄——黄视、绿视；视物模糊

## 2026 年陶老师主管初级护资 500 考点 考前最后一搏预测【25】小时=199 元

1. 一点都没有学的：只刷题的，停止刷题，听课还有希望
2. 没有完全学明白的：刷了很多题了，停止刷题，听课还有希望
3. 学的一般的：边学边刷题的 直接听课补缺补漏
4. 学的很好的：也刷了很多题了，停止刷题，补缺补漏锦上添花



可以让你提高 20-30 分的网课 可以让你提分的巧记

主管初级护资【考前 500 考点视频】时间安排：

1. 内外妇儿+人文 500 考点预测 【23】 小时（提供电子版讲义）
  2. 中医基础知识讲解 【2】 小时（提供视频）
- （4 月 1-4 号更新完毕，1 号中午 12 点 30 分更新，一直看到考试结束）

### 2026 陶老师 500 考点预测（24-26）——洋地黄中毒处理

洋地黄中毒处理：【陶老师巧记】停黄补钾苯妥英钠，缓慢就用阿托品

- 洋地黄中毒治疗
- ①立即停用，成年人 $<60$ ；婴幼儿 $<80$
  - ②快速心律失常者，血钾不低用苯妥英钠
  - ③无苯妥英钠就用利多卡因，血钾低者用静脉补钾
  - ④陶老师教你怎么判断低/高钾：正常钾离子  $3.5-5.5\text{mmol/l}$
  - ⑤低钾表现：(1) $<3.5\text{mmol/l}$  (2)U 波 (3)四肢乏力
  - ⑥高钾表现：(1) $>5.5\text{mmol/l}$  (2)T 波高尖 (3)心脏骤停
  - ⑦③严禁使用电复律，因易导致心室颤动；
  - ⑧④有房室传导阻滞、缓慢心律失常者可用阿托品，一般安置临时心脏起搏器。



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

### 2026 陶老师 500 考点预测（27-30）——急性左心衰治疗方法

陶老师巧记：端坐吸氧腿下垂，强心利尿打吗啡，血管扩张硝普钠。

- |    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 体位 | 减少静脉回流，置病人于两腿下垂坐位或半卧位                                      |
| 吸氧 | 高流量（6~8L/min）氧气，加入 20%~30%乙醇湿化，降低肺泡及气管内泡沫的表面张力，使泡沫破裂，改善肺通气 |
| 镇静 | 吗啡不仅具有镇静作用，还具有扩张静脉及小动脉的作用，减轻心脏负担                           |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
点击右下角微信联系陶老师

作用：降低心肌耗氧量

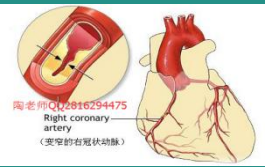
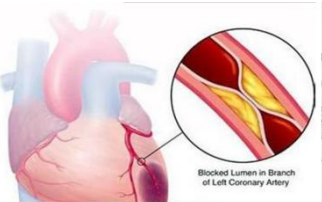
## 2026 陶老师 500 考点预测 (31-33) ---脑栓塞 脑血栓 脑出血

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 脑栓塞                       | 房颤、栓子、堵塞         |
| 脑血栓                       | 高脂血症、脑血管形成、栓子、堵塞 |
| 脑出血                       | 高血压              |
| 临床表现三者都一致：偏瘫 失语 口眼歪斜 意识障碍 |                  |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (34-38) ---心绞痛和心肌梗死临床表现的鉴别

|      | 心绞痛                  | 心肌梗死                                               |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 诱因   | 体力劳力、情绪激动、受寒、饱食等     | 不常有                                                |
| 部位   | 胸骨体中、上段后，可放射至左肩、左臂内侧 | 相同，但可在较低位置或上腹部                                     |
| 性质   | 压榨（迫）性或紧缩性           | 程度更剧烈，最早出现的症状疼痛                                    |
| 持续时间 | 短（3~5 分钟渐消失，15 分钟内）  | 长（数小时或 1~2 天）1 小时以上                                |
| 发作频率 | 频繁                   | 不频繁                                                |
| 硝酸甘油 | 显著缓解                 | 不能缓解                                               |
| 心电图  | ST 段压低               | 1. 病理性 Q 波；2. ST 段弓背向上抬高；3. T 波倒置。【陶老师巧记】QQ 喝高了倒着走 |
| 心肌酶  | 正常                   | 升高                                                 |
| 血压   | 高或者无显著变化             | 常降低、甚至休克                                           |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (39-40) ---心绞痛及心肌梗死机制

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 心绞痛发病机制  |   <p>冠动脉硬化→冠脉管腔狭窄和（或）部分分支闭塞→冠脉血流减少→心肌缺血、缺氧→缺氧（血）后代谢产物，刺激心脏内的传入神经末梢→心绞痛。</p>                    |  <p>扫码获取陶老师<br/>免费题库、免费视频</p> |
| 心肌梗死发病机制 |   <p>在冠状动脉严重狭窄的基础上，冠状动脉血供应急剧减少或中断，使心肌缺血达 20-30 分钟以上，即可发生急性心肌梗死。<br/>（机制：斑块破裂--血栓形成--堵塞血管）</p> |                                                                                                                    |

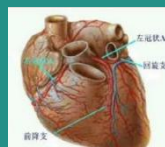
## 2026 陶老师 500 考点预测 (41) ---心肌梗死心电图特征性改变

宽而深的 Q 波; ST 段弓背向上抬高 T 波倒置

【陶老师巧记】: QQ 喝高了倒着走, 被车撞死了

QQ—异常 Q 波 高: S-T 段弓背向上抬高

倒: T 波倒置 死: 心肌梗死



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (42-44) ---心肌酶记忆

【陶老师巧记】

(1) 诊断心肌梗死特异性最高的指标是: 肌钙蛋白—该死 (钙—心肌梗死)—排第一位

(2) 急性心肌梗死时, 持续时间最长的血清酶是: 乳酸脱氢酶

【陶老师巧记】想要脱掉这身肥肉变轻, 是个漫长的过程

(3) 心肌梗死患者变化高峰出现最早的是: 肌红蛋白 (去天安门早起看五星红旗高高升旗)

(4) 肌酸磷酸激酶同工酶是出现最早、恢复最早的酶—排第二位

【陶老师巧记】: 容易激动的人, 最早发火, 恢复得也最快

## 2026 陶老师 500 考点预测 (45) ---心电图定位

| 导联 | 位置                                  |
|----|-------------------------------------|
| V1 | 胸骨右缘 4 肋间隙—有意思 (右-V1-第 4 肋)         |
| V2 | 胸骨左缘 4 肋间隙—二 (V2) 货, 你作 (左) 死 (第四肋) |
| V3 | V2 与 V4 的中点                         |
| V4 | 左锁骨中线与 5 肋间隙交点—有四就有五                |
| V5 | V4 水平与腋前线交点—有五就有四                   |
| V6 | V4 水平与腋中线交点                         |



## 2026 年陶老师主管初级护资 500 考点 考前最后一搏预测【25】小时=199 元

1. 一点都没有学的: 只刷题的, 停止刷题, 听课还有希望

2. 没有完全学明白的: 刷了很多题了, 停止刷题, 听课还有希望

3. 学的一般的: 边学边刷题的 直接听课补缺补漏



4. 学的很好的：也刷了很多题了，停止刷题，补缺补漏锦上添花

## 可以让你提高 20-30 分的网课 可以让你提分的巧记

主管初级护资【考前 500 考点视频】时间安排：

1. 内外妇儿+人文 500 考点预测 【23】 小时（提供电子版讲义）

2. 中医基础知识讲解 【2】 小时（提供视频）

（4 月 1-4 号更新完毕，1 号中午 12 点 30 分更新，一直看到考试结束）



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

| 胸前导联 | 反映水平面情况        |               |
|------|----------------|---------------|
| 前间壁  | $V_1 \sim V_3$ | 【陶老师巧记】小三插在中间 |
| 前壁   | $V_3 \sim V_5$ |               |
| 前侧壁  | $V_4 \sim V_6$ |               |
| 广泛前壁 | $V_1 \sim V_5$ |               |
| 后壁   | $V_7 \sim V_9$ |               |
| 下壁   | II、III、aVF     |               |

【陶老师巧记】

1. 高侧壁：I，aVL（高乐高）

2. 和二(II)三(III)个情妇(F-aVF)搞地下(下壁)情

3. 前间 123，前壁 345，广前 1-5 见 L 为侧，见 F 为下壁



## 2026 陶老师 500 考点预测（46-48）——急性心肌梗死治疗

|       |        |                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般治疗  | 休息     | 急性期绝对卧床 12h，24h 床上活动，3 日床边活动，4 天增加活动<br>【陶老师巧记】12 小时绝对 12-24 小时床上 1-3 床边 4-7 天房间 1 周后出房间                                                                                                                    |
|       | 吸氧     | 急性期 4~6L/min；急性肺水肿 6~8L/min 并以 20%-30%乙醇湿化                                                                                                                                                                  |
|       | 抗凝     | 氯吡格雷 300mg+阿司匹林 300mg 嚼服（首次剂量）<br>防止血栓进一步扩大和新血栓形成，观察有无出血倾向                                                                                                                                                  |
|       | 止痛     | 疼痛是急性心肌梗死病人最主要的护理问题，吗啡止痛                                                                                                                                                                                    |
| 心肌再灌注 | 溶栓     | 发病后的 3-6 小时内（时间窗）进行 3 小时内溶栓效果和 PCI（放支架）<br>溶栓药物：重组链激酶在 1 小时内静脉滴注 150 万 U<br>尿激酶 150 万~200 万 U，30 分钟内静滴<br>血栓溶解指标：①抬高的 ST 段 2 小时内回落 >50%；②2 小时内胸痛消失；③2 小时内出现再灌注性心律失常；④血清 CK-MB 酶峰值提前出现；⑤也可根据冠状动脉造影直接判断溶栓是否成功 |
| 心律失常  | 室性心律失常 | 急性心肌梗死患者死亡的主要原因。多发生于病后 2d 内，前 24h 内发生率最高，以室性心律失常最多见。室颤是急性心梗早期患者的主要死因，<br>治疗：非同步电复律                                                                                                                          |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

## 2026 陶老师 500 考点预测 (49) --- 休克分类

## 休克共同特征: 有效循环血量减少

1. 低血容量性休克: 包括失血性休克 (如外伤、消化道出血等导致血液大量丢失) 和失液性休克 (如严重呕吐、腹泻等导致体液大量丧失); 2. 感染性休克: 常由严重感染引起; 3. 心源性休克: 由于心脏功能急剧减退导致; 4. 过敏性休克: 因过敏反应引起

## 2026 陶老师 500 考点预测 (50-55) --- 心脏病瓣膜病和各种心

|          | X 线 | 杂音位置             | 杂音性质         |
|----------|-----|------------------|--------------|
| 二尖瓣狭窄    | 梨形心 | 心尖区              | 舒张期隆隆样杂音     |
| 二尖瓣关闭不全  | 球形心 | 心尖区              | 收缩期吹风样杂音     |
| 主动脉瓣狭窄   | /   | 主动脉瓣区            | 收缩期粗糙、响亮性杂音  |
| 主动脉瓣关闭不全 | 靴形心 | 主动脉瓣二区胸骨左缘第 3 肋间 | 舒张期吹风样/叹息样杂音 |

|     |                 |        |               |
|-----|-----------------|--------|---------------|
| 梨型心 | 二尖瓣狭窄           | 陶老师巧记: | 二人吃梨不让梨, 心胸狭窄 |
| 靴型心 | 主动脉关闭不全, 法洛四联症  | 陶老师巧记: | 猪血好吃, 法师的靴子   |
| 普大心 | 全心衰、心肌炎(病)、心包积液 | 陶老师巧记: | 一心向外, 主动穿靴    |
| 球型心 | 二尖瓣关闭不全         | 陶老师巧记: | 2B 算个球        |

## 2026 年陶老师主管初级护资 500 考点 考前最后一搏预测【25】小时=199 元

1. 一点都没有学的: 只刷题的, 停止刷题, 听课还有希望
2. 没有完全学明白的: 刷了很多题了, 停止刷题, 听课还有希望
3. 学的一般的: 边学边刷题的 直接听课补缺补漏
4. 学的很好的: 也刷了很多题了, 停止刷题, 补缺补漏锦上添花



### 可以让你提高 20-30 分的网课 可以让你提分的巧记

## 主管初级护资【考前 500 考点视频】时间安排:

1. 内外妇儿+人文 500 考点预测 【23】 小时 (提供电子版讲义)
2. 中医基础知识讲解 【2】 小时 (提供视频)

(4 月 1-4 号更新完毕, 1 号中午 12 点 30 分更新, 一直看到考试结束)



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

看书做题 1 天, 不如听课 1 小时

## 2026 陶老师 500 考点预测 (56-58) ----高血压分级

血压分级：低标准分级特点 20 进制/10 进制

| 类别     | 收缩压 mmHg (二十进制) | 舒张压 mmHg (十进制) |
|--------|-----------------|----------------|
| 正常血压   | <120            | <80            |
| 正常高值   | 120~139         | 80~89          |
| 1 级高血压 | 140~159         | 90~99          |
| 2 级高血压 | 160~179         | 100~109        |
| 3 级高血压 | ≥180            | ≥110           |

陶老师总结：高血压 高血压 就高不就低，舒张压/收缩压哪个分级高，就以哪个为准

## 2026 陶老师 500 考点预测 (59) ----高血压危险分层

| 危险因素           | 血压 (mmHg) |       |       |
|----------------|-----------|-------|-------|
| 其他危险因素及病史      | 1 级       | 2 级   | 3 级   |
| 无其他危险因素        | 低危 1      | 中危 2  | 高危 3  |
| 1~2 个危险因素      | 中危 2      | 中危 2  | 很高危 4 |
| ≥3 个危险因素或靶器官损害 | 高危 3      | 高危 3  | 很高危 4 |
| 有并发症临床情况或糖尿病   | 很高危 4     | 很高危 4 | 很高危 4 |

陶老师巧记：记住很高危就可以了，只要高血压合并了其他疾病都是极高危

主要危险因素包括：

①年龄：男&gt;55 岁，女&gt;65 岁；②吸烟；③高胆固醇血症；④糖尿病；⑤家族早发冠心病史，发病年龄男性&lt;55 岁，女性&lt;65 岁

陶老师巧记：一个抽烟肥胖的老男人得了高血压，他的爸爸也是高血压死的（遗传因素）

陶老师巧记总结——高血压危险因素判断三部曲：1. 看到三级高血压就选择很高危；2. 看到糖尿病/脑出血/肾病也选很高危也选极高危；3. 三高人群：二级高血压 3 个危险因素选择高危

## 2026 陶老师 500 考点预测 (60-62) ----高血压急性并发症

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 高血压危象 | 表现有头痛、烦躁、眩晕、心悸、气急、视力模糊、恶心、呕吐等症状，收缩压可达 260mmHg，舒张压可达 120mmHg 以上。        |
| 高血压脑病 | 表现：以脑部症状和体征为特点，严重头痛、呕吐、意识障碍、精神错乱、抽搐，甚至昏迷。因血压过高引起脑血管调节异常，脑灌注过多，造成脑水肿引起。 |
| 脑血管病  | 脑出血是高血压死亡最常见原因，也是最严重<br>(怎么判断脑出血？临床表现为头痛、偏瘫、失语)                        |

【陶老师巧记】高血压危象与高血压脑病二者区别

第一步看血压，是否超过 260/120 (有的时候血压是 220/120 以上)

第二步看表现，脑子有没有问题 (昏迷 意识模糊)

高血压危象不会出现大脑的问题也就是不会昏迷，

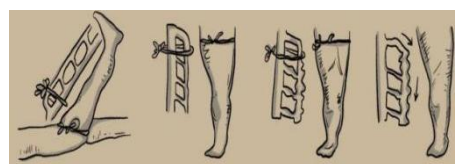
而高血压脑病，既然有脑病了肯定是脑子坏了，脑子坏了就要昏迷

出现高血压危象和高血压脑病怎么办？迅速降低血压——硝普钠，可以短时间迅速降低血压



|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | 后期血管周围纤维组织增生，将血管和神经粘连在一起，神经受到反复刺激，病人表现为剧烈疼痛 <b>【陶老师巧记】</b> 只要提到我有障碍，我就心痛 |
| 组织坏死期 | 患肢动脉完全闭塞，发生干性坏疽，此后，坏死组织可自行脱落，在残端留下经久不愈的溃疡创面                              |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (68) ----下肢静脉曲张辅助检查



**【陶老师巧记】** 1. 大隐静脉瓣膜功能试验 (Terndelenburg): (天大地大; 大字隐去一点就是 T)

止血带大腿根部结扎站立，松止血带，血管从下往上迅速充盈→大隐静脉瓣膜功能不全，不松充盈→交通静脉瓣膜功能不全。

**【陶老师巧记】** 扎他 (T) 大腿

**【陶老师巧记】** 松带充盈大不全，不松充盈交不全

2. 深静脉通畅试验 (Perthes): 记忆方法 (好朋友，交情颇深 (Perthes-颇深-深静脉))

用来决定能否手术的关键检查 **【陶老师巧记】** 踢腿运动 (神 (S) 童踢腿) 下蹲 蹲的很深

3. 交通静脉瓣膜功能试验 (Partt): 用绷带做试验 **【陶老师巧记】** (交，绷带叫屈，无 TT)

治疗: 非手术→弹力袜。单纯性下肢静脉曲张→首选高位结扎+剥脱术

Perthes 阳性病人绝对不能手术。

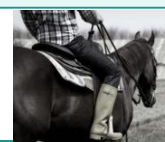
## 2026 陶老师 500 考点预测 (69) ----先天性心脏病

| 分类             | 左→右      |              |             | 右→左             |
|----------------|----------|--------------|-------------|-----------------|
|                | 房间隔缺损    | 室间隔缺损        | 动脉导管未闭      | 法洛四联症           |
| 杂音部位           | 第 2、3 肋间 | 第 3、4 肋间     | 第 2 肋间      | 第 2-4 肋间        |
| 时间             | 收缩期      | 收缩期          | 收缩期和舒张期     | 收缩期             |
| 性质             | 喷射样      | 粗糙吹风样        | 连续性机器样      | 喷射性             |
| P <sub>2</sub> | 亢进、固定分裂  | 亢进           | 亢进          | 减低              |
| X 线检查<br>房室增大  | 右房、右室大   | 双室大<br>左心房可大 | 左室大<br>左房可大 | 右心室大，心尖上翘，心影呈靴形 |
| 肺门舞蹈           | 有        | 有            | 有           | 无               |
| 主动脉结           | 不大       | 不大           | 增大          | 不大              |
| 肺动脉段           | 凸出       | 凸出           | 凸出          | 凹陷              |
| 肺野             | 充血       | 充血           | 充血          | 清晰              |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (70) ----法洛四联症

**陶老师巧记:** 飞侠失去四大坐骑

飞侠: 肺动脉狭窄 失去: 室缺 四大: 右心室肥大 坐骑: 主动脉骑跨



|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 临床表现 | 1. 青紫是最早出现的临床表现                                                             |
|      | 2. 蹲踞症状：因为下蹲的时候体循环的压力就会暂时的增高，以抵抗右室的血进入主动脉，使缺氧症状减轻                           |
| 诊断   | 3. 杵状指 慢性缺氧都会有的表现                                                           |
|      | 4. 阵发性缺氧发作本来肺动脉就狭窄，在这个基础上如果又出现了痉挛，那就引出肺动脉梗阻了，加重脑缺氧。出现头痛头昏、惊厥                |
| 治疗   | 5. 活动耐力下降                                                                   |
|      | 由于肺循环缺血，所以 X 线上肺动脉段凹陷，肺野清晰。右心室增大， <b>心影呈“靴形”</b>                            |
|      | 确诊用心导管检查。【陶老师巧记】“法师的靴子”                                                     |
|      | 1. 一般治疗：限制活动、 <b>鼓励饮水、及时补液</b> 、防治脱水和感染、 <b>预防脑血栓</b> 、脑脓肿等                 |
|      | 2. 阵发性缺氧的治疗： <b>取膝胸卧位</b> ；吸氧； <b>普奈洛尔（心得安）-降低心肌耗氧量</b> ；吗啡，必要时皮下注射；纠酸，碳酸氢钠 |
|      | 3. <b>外科</b> ：（手术最佳时间：心功能改善后）                                               |
|      | <b>轻症</b> ：手术年龄以 5~9 岁为宜，但临床症状明显者在生后 6 个月后行根治术；                             |
|      | <b>重症</b> ：待一般状况改善后（心功能改善）再行根治术                                             |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

|        |             |                                |
|--------|-------------|--------------------------------|
| 房缺     | 右房右室增大      | 第二心音固定分裂                       |
| 室缺     | 左右心室增大      | 胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及 III~IV 级全收缩期杂音 |
| 动脉导管未闭 | 除了右心房以外三腔扩大 | 胸骨左缘第 2 肋间有粗糙响亮的连续性机器样杂音       |
| 法洛四联症  | 肺动脉狭窄占主要    | 肺动脉段凹陷、心影呈“靴型”                 |

## 版权声明

本课程已向国家版权局申请版权

本课程未经授权不得以任何形式分享、共享、转载、转卖给任何第三方。

第三方指除了学生本人之外的任何人，包括你的至爱亲朋、手足兄弟。

已和专业律师事务所深度合作，由专人进行市场监督。

本公司近期累计起诉 8 起盗版案例，全部胜诉。

特此声明，违者一定追究法律责任

## 2026 陶老师 500 考点预测（71）——如何选择 雾化 吸痰

1. 痰液粘稠 选择雾化吸入
2. 病人出现窒息的表现（呼吸困难 发绀）——选择立即吸痰（救命要紧）

## 2026 陶老师 500 考点预测 (72) —— 如何选择气体交换受损 清理呼吸道无效 低效性呼吸型态

1. 题目中如果出现呼吸困难、气促症状，没有说痰液有问题就——选择气体交换受损
2. 题目中如果出现痰液黏稠不易咳出就选择——清理呼吸道无效
3. 低效性呼吸型态不属于护理考试范围是迷惑选项——不选（如果看到三凹征就一定选）

## 2026 陶老师 500 考点预测 (73) —— 轻重症肺炎鉴别

1. 轻症肺炎=发热+咳嗽+气促+萎靡不振+三凹征；2. 重症肺炎=呼吸症状+全身中毒+循环、神经、消化系统（又叫休克型肺炎、中毒性肺炎，区别：其他系统受累）

循环系统

肺炎合并心力衰竭的表现：以右心衰为主要临床表现

- ①呼吸加快(>60 次/分)
- ②心率增快(婴儿>180 次/分，幼儿>160 次/分，儿童>140 次/分)
- ③突然极度烦躁不安，面色苍白或发灰、发绀
- ④心音低钝、颈静脉怒张(右心衰)
- ⑤肝迅速增大(右心衰)
- ⑥尿少或无尿，血压<90/60mmHg—重点观察 具备前五项即可诊断



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (74-76) —— 肺炎的分类

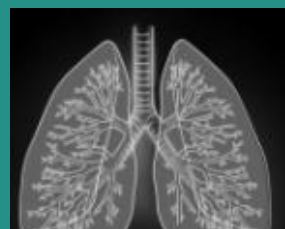
【陶老师巧记联想记忆】按照解剖分类：

1. 大叶性肺炎—肺泡—肺炎链球菌—中青年—铁锈色痰 陶老师巧记：青年人—谈恋爱—大电灯泡
2. 小叶性肺炎—支气管——葡萄球菌—老年人—黄色脓痰
3. 间质性肺炎—在肺泡及支气管之间：

炎症累及一大片肺泡，一个肺叶→大叶性肺炎

炎症累及细支气管→小叶性肺炎(支气管肺炎)，

炎症累及肺间质→间质性肺炎—网格状、磨玻璃影



## 2026 陶老师 500 考点预测 (77-80) —— 肺炎治疗药物

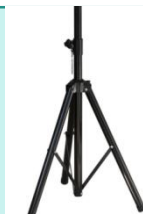
【陶老师巧记法谐音记忆】：

肺炎链球菌：首选青霉素——青年人谈恋爱

肺炎支原体和衣原体：首选大环内酯类抗生素 如红霉素 阿奇霉素

葡萄球菌肺炎：首选头孢或半合成青霉素(XX 西林)

耐甲氧西林金葡菌感染(MRSA)：选用万古霉素治疗



看书做题 1 天，不如听课 1 小时

【陶老师巧记口诀】：啊！我们要大力支援红军

啊——阿奇霉素 大力-大环内酯类 支援-衣原体、支原体 红-红霉素

扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (81-85) ----支气管扩张

|            |                                                                                   |                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 慢性咳嗽和大量脓性痰 | 咳嗽<br>咳痰                                                                          | 晨起及晚上临睡时咳嗽和咳痰尤多，痰量达数百毫升， <b>将痰放置数小时后可分三层，上层为泡沫、中层为黏液、下层为脓性物和坏死组织</b> |
| 咯血         | 反复咯血为本病的特点： 少量咯血为<100mL/d；中量咯血为 100-500mL/d；<br>大量咯血为>500mL/d 或 1 次咯血量>100mL      |                                                                      |
| 体征         | 病变部位可闻及局限性、固定性湿啰音                                                                 |                                                                      |
| 病因         | 婴幼儿期支气管-肺组织感染是支气管扩张最常见的原因。病因以婴幼儿期的麻疹、百日咳、支气管肺炎最为常见 <b>【陶老师巧记】百日咳芝麻——百日咳、支扩、麻疹</b> |                                                                      |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (86-90) ----痰液的区分

【陶老师巧记法谐音记忆】：

黄脓痰——金黄色葡萄球菌 草绿色痰——铜绿假单胞菌(绿脓杆菌) 恶臭味——厌氧菌  
 铁锈色痰——肺炎链球菌 砖红色胶冻样痰——克雷伯杆菌 果酱样痰——肺吸虫  
 粉红色泡沫痰——急性左心衰 痰中呈红色或红棕色——支气管扩张，肺癌、肺结核  
 巧克力色痰——阿米巴肺脓肿 黏稠易拉丝——真菌

## 2026 陶老师 500 考点预测 (91-93) ----支气管扩张体位引流

【陶老师巧记法谐音记忆】：

- 体位引流排痰(肺脓肿、支扩)：健侧卧位——水往低处流，病变部位在上  
(**陶老师巧记**：病人是上帝——有病的一侧在上面)
- 患有高血压、心力衰竭及高龄病人禁止体位引流——怕高
- 防止咯血窒息：患侧卧位——防止血液流入气管 (**陶老师巧记**：压迫止血)



## 2026 陶老师 500 考点预测 (94-95) ----COPD 的病因及发展因素

【陶老师巧记】：

吸烟：是发病的重要因素

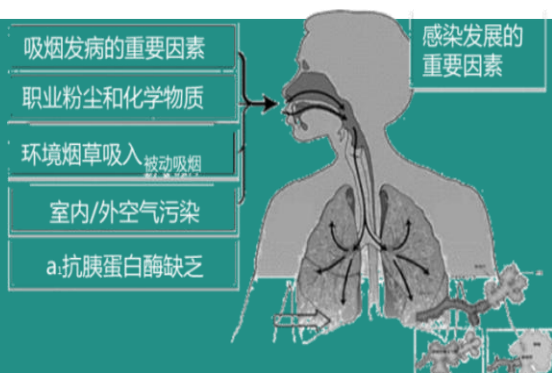
(吸烟有害健康 0-1，无一有)

(巧记：饭后一支烟，送君上西天)

感染：是病情发展加重的重要因素

(1—多 有—更重)

遗传因素：α1 抗胰蛋白酶缺乏也是病因

**巧记**：吸烟有害健康(无→有)，感染加重病情(有→更重)

阿姨不爱吃蛋( $\alpha 1$  抗胰蛋白酶缺乏--COPD)

## 2026 陶老师 500 考点预测 (96-97) ----COPD 的机制及诊断

COPD 指具有气道阻塞特征的慢性支气管炎和肺气肿。

气道阻塞的轻重通常由肺功能  $FEV_1/FVC$  (一秒率) 降低的程度来确定  $FEV_1/FVC < 0.7$ **巧记:**  $FEV_1/FVC < 0.7$  —— 7 个字母

COPD 的最大特点: 不完全性可逆的气流受限 (治疗后不能完全缓解); 支气管哮喘是完全可逆的, 两者注意区别。

COPD 早期为小气道功能异常——慢阻肺——小气道 (**巧记:** 年龄小, 走路慢)

吸烟——慢性支气管炎——阻塞性肺气肿——COPD——肺心病

## 2026 陶老师 500 考点预测 (98-99) ----COPD 的治疗及护理

| 类别     | 急性期                                    | 稳定期                            |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 氧疗     | 鼻导管、低流量 (1-2L/min)                     | 低流量吸氧 1-2L/min, 吸氧时间 > 15h/d   |
| 抗感染    | 最重要                                    | 一般不用                           |
| 支气管舒张剂 | 糖皮质激素                                  | 沙丁胺醇气雾剂、异丙托溴铵 (对抗迷走神经) 等; 茶碱类; |
| 其他     | 机械通气、补充液体和电解质等                         | 戒烟, 脱离污染环境; 祛痰药, 康复治疗锻炼        |
| 镇咳     | 老人、体弱多痰者禁用中枢性镇咳剂 (可待因) 会增加气道分泌物 → 加重阻塞 | 必要时可用                          |
| 饮食     | 给予高热量、高蛋白质、高维生素、保证足够的饮水量, 有助于痰液的稀释     |                                |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (100-104) ----氧流量选择

**总结解答如何选择 持续低流量、高流量; 间断低流量、高流量**

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 1. 慢性肺病 | 全部选择持续低流量、急性肺病选择间断高流量  |
| 2. 心脏问题 | (慢性、急性) 全部选择间断高流量加乙醇湿化 |
| 3. 肺心病  | 持续低流量                  |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (105-110) ----肺心病的发病原因及机制

**【陶老师总结重要考点】:**

吸烟——慢支——肺气肿——COPD——缺氧——肺动脉高压——肺心病

最常见的病因→COPD (慢阻肺) 肺心病主要机制→肺动脉高压

肺动脉高压形成最重要机制→缺氧造成肺小动脉收缩 (功能因素);

失代偿重要的诱发因素以及急性加重的重要诱因→感染



## 2026 陶老师 500 考点预测 (111-114) ----肺心病的临床表现

|    | 肺、心功能代偿期                                                                       | 肺、心功能失代偿期                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 症状 | 原发病表现即慢支+阻塞性肺气肿的症状                                                             | <b>呼衰</b> （呼吸困难加重，加重时出现神志恍惚、谵妄、躁动、抽搐、生理反射迟钝等肺性脑病的表现）<br><b>右心衰症状</b> ：气促，食欲不振，恶心，少尿等             |
| 体征 | ①肺气肿征；②下肢轻微浮肿；③ <b>心音遥远、P<sub>2</sub>亢进，肺动脉高压征</b> ，剑突下心脏搏动；④发绀；⑤ <b>颈静脉充盈</b> | <b>呼吸衰竭</b> ：明显发绀；球结膜充血、水肿<br><b>右心衰</b> ： <b>颈静脉怒张</b> 、剑突下收缩期杂音、肝大、腹水征阳性， <b>肝颈静脉回流阳性(最特异)</b> |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (115-116) ----呼吸衰竭

|      | I 型呼衰(只有一个异常)                                          | II 型呼衰(两个指标都异常)                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性质   | 缺氧性呼衰                                                  | 高碳酸性呼衰                                                                                        |
| 发病机制 | 肺换气障碍                                                  | 肺泡通气不足                                                                                        |
| 血气分析 | $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ , $\text{PaCO}_2$ 降低或正常 | $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ , 伴 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$<br><b>【陶老师巧记】2-50, 二百五</b> |
| 常见疾病 | 严重肺部感染、急性肺栓塞、ARDS                                      | COPD                                                                                          |
| 治疗   | 高浓度吸氧 (>35%)                                           | 低浓度吸氧 (<35%)                                                                                  |

**【陶老师巧记】——如何区分 I 型和 II 型呼吸衰竭？——联想记忆法：**

- I 型就代表只有一个指标异常，那就是  $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$
- II 型既然是 2 肯定两个指标都有异常  $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ , 伴  $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- 想像班级考第一名需要考个高分，考第二名分数就要比第一名低



## 2026 陶老师 500 考点预测 (117-120) ----哮喘发病机制



|      |                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本质   | 多种炎症细胞（主要是嗜碱性粒细胞释放组胺/嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T 细胞、中性粒细胞、气道上皮细胞等）和细胞组分 IgE 参与的 <b>气道慢性炎症性疾病</b><br><b>【陶老师巧记】“酸菜肥肉巨提中气”→嗜酸粒 C、肥大细胞、巨噬细胞、T 细胞、中性粒 C、气道上皮细胞</b> |
| 病因   | 病因尚不十分清楚，可能受遗传和环境因素(感染、过敏等)的双重影响。 <b>花粉、尘螨、动物的毛屑</b>                                                                                             |
| 发病机制 | ①哮喘的基本特征是 <b>嗜酸性粒细胞浸润为主的慢性气道炎症</b> ；气道慢性炎症可导致气道高反应性 <b>接触变应原触发或引起慢性气道炎症</b>                                                                      |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
点击右下角微信联系陶老师

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | ②哮喘的重要发病机制是气道高反应性(但气道高反应性并不一定会发哮喘),控制气道高反应性主要用可吸入糖皮质激素。 <b>哮喘本质——气道慢性炎症+平滑肌痉挛</b> |
| 结局 | 气道反应性的增加,通常出现广泛多变的可逆性气流受限,引起反复发作性的喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状,常在夜间和(或)清晨发作、加剧,多数患者可自行缓解或经治疗缓解  |

## 【陶老师巧记总结】

哮喘发病有关细胞和抗体:嗜酸性粒细胞、肥大细胞、IgE

陶老师巧记:一个喜欢吃酸菜的肥胖小男孩,得了哮喘

记忆:一(IgE)个喜欢吃酸(嗜酸性粒细胞)菜肥胖(肥大细胞)小(哮喘)男孩,得了哮喘



## 2026 陶老师 500 考点预测 (121-125) ----哮喘临床表现

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
|    | <b>反复发作性的呼气性呼吸困难</b> 或发作性胸闷和咳嗽,严重者被迫采取坐位或呈端坐呼吸,干咳或咳大量白色泡沫痰,甚至出现发绀等   |
| 症状 | 哮喘症状可在数分钟内发作,严重的哮喘发作持续 24 小时以上至数天,用支气管舒张剂后缓解或自行缓解,发作超过 24 小时叫做哮喘持续状态 |
|    | 夜间或凌晨发作和加重是哮喘的特征之一                                                   |
| 体征 | 双肺闻及 <b>广泛的哮鸣音</b> 呼气尤其明显                                            |
|    | 危重哮喘 3 个体征:寂静肺、奇脉、胸腹反常运动<br>发作超过 24 小时 叫做哮喘持续状态 也是危重的表现              |

扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 【陶老师巧记】哮喘是呼气性呼吸困难

有首歌词是北风那个吹 记忆成呼啸的北风 呼一呼气性呼吸困难 啸——哮喘

## 2026 陶老师 500 考点预测 (126-130) ----哮喘治疗药物

| 平喘药物            | 代表药物       | 给药途径                | 适用人群                                   |
|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------|
| $\beta_2$ 受体激动剂 | 沙丁胺醇; 特布他林 | 首选吸入、口服或注射用于严重      | 控制急性发作的首选药                             |
| 抗胆碱药            | 异丙托溴胺      | $\beta_2$ 受体激动剂联合吸入 | 夜间哮喘及多痰的患者                             |
| 茶碱类             | 氨茶碱        | 吸、口服或注射(用于严重)       | 心源性及支气管哮喘,不良反应是胃肠道、心血管症状(心律失常、心悸,心脏骤停) |
| 抗炎类             | 糖皮质激素      | 同上(吸入后漱口)           | 最有效的药物,长期抗炎                            |
|                 | 色苷酸钠       |                     | 预防发作 陶老师巧记:妹妹防色狼                       |
|                 | 白三烯调节剂     | 孟鲁司特、扎鲁司特           | 阿司匹林和运动诱发哮喘                            |
|                 | 酮替酚        |                     | 季节交替 陶老师巧记:四季交替                        |

## 【陶老师有关哮喘用药方式巧记】:

1、脱离变应原最重要、最有效的治疗措施

2、药物治疗:支气管舒张药( $\beta_2$ 受体激动剂,是缓解哮喘急性发作、症状的首选药)

(1) 支气管舒张药：沙丁胺醇、特布他林、沙美特罗、异丙托溴铵

**陶老师巧记：**沙特人最近点儿背；托塔李天王一身是胆



(2) 糖皮质激素是当前控制哮喘发作最为有效(不是最好的方法)的药物；吸入治疗是目前推荐长期抗炎治疗哮喘最常用的方法

**陶老师巧记：**控制愤怒情绪最好的办法就是发绩效奖金(绩—激素；效—有效)

(3) 色甘酸钠：非糖皮质激素抗炎药，可预防哮喘发作，不能作为治疗药。**陶老师巧记：**妹妹防色狼

(4) 哮喘不能用：吗啡 抑制呼吸中枢 **陶老师巧记：**你不要笑，好吗！一笑(哮喘)，吗(吗啡)

## 2026 陶老师 500 考点预测 (131-133) ----急性呼吸窘迫综合征 ARDS

|             |                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 呼吸困难        | 呼吸加快(最早出现)，呈进行性加重的呼吸困难，发绀。                                                                                                                                                                      |                                        |
| 动脉血气分析      | 动脉血氧分压( $\text{PaO}_2$ ) $\leq 60\text{mmHg}$ ；氧合指数 $[\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ (吸入氧的分数值)] $< 300\text{mmHg}$ 。<br><b>【陶老师巧记】</b> 氧气— $\text{O}_2$ —300；(正常值 400~500mmHg) 氧合指数降低是 ARDS 诊断的必备条件 |                                        |
| 原发病的治疗      | 是治疗 ARDS 的首要原则                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 纠正缺氧(最重要措施) | 高浓度给氧( $> 50\%$ ，避免长期用)，使 $\text{PaO}_2 \geq 60\text{mmHg}$ 或血氧饱和度( $\text{SaO}_2$ ) $\geq 90\%$                                                                                                |                                        |
| 机械通气        | 是纠正缺氧的主要措施，最常用的通气模式为呼气末正压(PEEP)通气<br><b>【陶老师巧记】</b> PEEP—APP 软件                                                                                                                                 |                                        |
| 给氧护理        | 措施                                                                                                                                                                                              | 迅速纠正低氧血症是抢救 ARDS 最重要措施                 |
|             | 浓度                                                                                                                                                                                              | 高浓度( $> 50\%$ )、高流量(4-6L/min)吸氧，以提高氧分压 |

### 版权声明

本课程已向国家版权局申请版权

本课程未经授权不得以任何形式分享、共享、转载、转卖给任何第三方。

第三方指除了学生本人之外的任何人，包括你的至爱亲朋、手足兄弟。

已和专业律师事务所深度合作，由专人进行市场监督。

本公司近期累计起诉8起盗版案例，全部胜诉

特此声明，违者一定追究法律责任



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (134-136) ----气胸的鉴别

|    | 闭合性气胸                        | 张力性气胸                     | 开放性气胸                 |
|----|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 病因 | 肋骨骨折                         | 较大肺泡裂伤支气管破裂               | 锐器火器弹片                |
| 特点 | 不继续发展闭合性伤口，肺萎陷 30%以下者，多无明显症状 | 进行性呼吸困难，伤口形成活瓣，颈静脉怒张，皮下气肿 | 继续漏气，开放性伤口呼吸有气体进出伤口响声 |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

## 【陶老师巧记】

闭合性气胸:肋骨骨折史—气体不进不出

开放性气胸:刺伤史—气体进出自由—有气体进出的声音—嘶嘶声—纵膈摆动

张力性气胸: COPD 病史—肺大泡破裂—气体只进不出—纵膈移位, 皮下气肿



## 2026 陶老师 500 考点预测 (137-140) ——气胸的处理

|      | 闭合性气胸                                                         | 张力性气胸        | 开放性气胸                    |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 胸片首选 | 不同程度肺萎缩                                                       | 肺完全塌陷、严重胸腔积气 | 肺萎缩, 大量胸腔积气              |
| 治疗   | 肺压缩量 $< 20\%$ 者先行观察, 1~2w 可自行吸收<br>$> 20\%$ 者先穿刺抽气自觉症状重者行闭式引流 | 立即穿刺抽气进行减压处理 | 立即将开放性变为闭合性(凡士林纱+棉垫覆盖伤口) |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (141) ——肺部听诊、叩诊音

正常人:清音      肺气肿、COPD:过清音      胸腔积液:浊音      肺部肿瘤:实音      气胸:鼓音  
急性肺水肿:两肺满布湿啰音      肺淤血:两肺底湿啰音  
支气管扩张:局限而固定的干、湿啰音      支气管哮喘:双肺布满哮鸣音



## 2026 陶老师 500 考点预测 (142-144) ——肺结核诊断

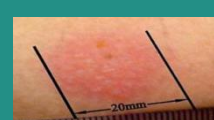
痰结核杆菌检查 痰中找到结核杆菌是诊断肺结核病最可靠的依据 PPD 试验: 48-72 小时后看皮试结果

| 硬结直径                                           | 反应  | 符号    |
|------------------------------------------------|-----|-------|
| $< 5\text{mm}$                                 | 阴性  | (-)   |
| 5-9mm                                          | 弱阳性 | (+)   |
| 10-19mm                                        | 阳性  | (++)  |
| $\geq 20\text{mm}$ 或 $< 20\text{mm}$ (出现水泡或坏死) | 强阳性 | (+++) |

## 【陶老师巧记】



PPD 皮试记忆: +看成中文汉字十; 5-9mm 小于 10mm 所以写成(+), 10-19mm 小于 20 所以写成(++);  $\geq 20\text{mm}$  小于 30mm 所以写成(+++)



## 2026 陶老师 500 考点预测 (145-146) ——抗结核药物不良反应口诀记忆

|          |                                                                                          |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 预防       | 做好呼吸道隔离, 预防传染如: 痰吐在纸上用火焚烧; 接种卡介苗(最有效的预防措施) 结核菌素实验(+) 或儿童新近转(+) 或密切接触史人可服用异烟肼预防——预-异(音相似) |             |
| 化疗药物不良反应 | 链霉素                                                                                      | 耳聋和肾功能损害    |
|          | 吡嗪酰胺                                                                                     | 肝功能损害关节疼痛   |
|          | 异烟肼                                                                                      | 周围神经炎、中毒性反应 |
|          | 乙胺丁醇                                                                                     | 球后视神经炎      |

看书做题 1 天, 不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
点击右下角微信联系陶老师

利福平

肝功能损害

## 【陶老师巧记】抗结核药物不良反应口诀记忆：

1. 喝酒后眼花摔一跤屁股痛一周：喝酒(乙醇-乙胺丁醇)眼花(球后神经炎)屁股(吡嗪酰胺)痛(痛风、关节疼痛)一(异烟肼)周(周围神经炎-四肢麻木)
2. 以后一周练听力，利肝安胃肠：以(乙胺丁醇)后(球后神经炎)一(异烟肼)周(周围神经炎-四肢麻木)练(链霉素)听力(耳聋)，利(利福平)肝(肝功能损害)安胃肠
3. 利福平及其代谢物为橘红色，服后大小便、眼泪等为橘红色 【陶老师巧记】年终发红利
4. 链霉素副作用-神经损害、肾功能损害、听力障碍
5. 异烟肼——周围神经炎(四肢麻木)-异烟-异样的感觉-麻木



## 2026 陶老师 500 考点预测 (147-150) ----胃内细胞



胃黏膜层有丰富的腺体，由功能不同的细胞组成：

|      |                        |          |
|------|------------------------|----------|
| 主细胞  | 分泌胃蛋白酶原和凝乳酶原           | 胃底和胃体    |
| 壁细胞  | 分泌盐酸和抗贫血因子(内因子)        | 胃底和胃体    |
| 黏液细胞 | 分泌碱性黏液，有保护黏膜、对抗胃酸腐蚀的作用 | 胃底、胃窦和胃体 |
| G 细胞 | 分泌促胃液素                 | 胃窦       |
| 嗜银细胞 | 功能尚不明                  | 胃底       |

## 【陶老师巧记】

1. 煮鸡蛋——主细胞分泌胃蛋白酶
2. 鼻炎、鼻出血——壁细胞分泌盐酸和抗贫血因子
3. 黏液细胞当然分泌粘液
4. G 细胞——G 和胃长得相似
5. 除了 G 细胞只在胃窦，其他的细胞都在胃底和胃体



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (151-153) ----口炎分类

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 鹅口疮(雪口病) | 白色念珠菌感染 【陶老师巧记】：鹅毛是白色的                    |
| 新生儿口炎    | 多由产道感染或使用不洁奶具、哺乳时乳头不洁所致                   |
| 疱疹性口腔炎   | 单纯疱疹病毒感染                                  |
| 溃疡性口腔炎   | 链球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等感染<br>【陶老师巧记】：中国足球，让我崩溃 |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (154) ----口腔炎临床表现

| 疾病       | 特点                    | 备注                                                  |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 鹅口疮(雪口病) | 口腔黏膜表面出现白色乳凝块样物(不易擦去) |                                                     |
| 疱疹性口腔炎   | 上面覆盖黄白色纤维素性渗出物        | 疱疹性咽峡炎(柯萨奇病毒)鉴别，发生于夏秋季，疱疹主要在咽部和软腭，不累及牙龈、颊黏膜，颌下淋巴结不大 |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

溃疡性口腔炎

灰白色假膜（易拭去）

颌下淋巴结肿大

## 【陶老师口炎巧记方法】

1. 鹅口疮：白色念珠菌感染-口腔黏膜表面出现白色乳凝块样物（不易擦去）-鹅怎么赶不走

【陶老师巧记】鹅毛是白色的，鹅怎么也赶不走--所以鹅口疮都和白有关

2. 疱疹性口腔炎：疱疹病毒感染-上面覆盖黄白色纤维素性渗出物--碘苷--碘酒黄色的

【陶老师巧记】这个男人很黄很色，经常不注意，然后得疱疹了（黄色-疱疹性口腔炎）

3. 溃疡性口腔炎：链球菌-灰白色假膜（易拭去）--金霉素

【陶老师巧记】足球让我崩溃，精神崩溃的那一刻脸色灰白--像个白色的足球，没精打采



## 2026 陶老师 500 考点预测（155-157）----口炎治疗护理

1. 鹅口疮（重要考点一必考）

治疗用：制霉菌素；清洁用：2%碳酸氢钠；止痛用：2%利多卡因；预防用：生理盐水

【陶老师巧记】治对制，清对氢，止痛就用利多卡因。

2. 鹅口疮（白色乳凝块）疱疹性口腔炎（黄白色纤维素性渗出物）溃疡性口腔炎（灰白色假膜）

3. 疱疹性口腔炎、丹毒和破伤风患者都具有传染性，需实行接触隔离

4. 患者沐浴、糖尿病患者的运动时间、口腔炎患儿的口腔清洁均为餐后

扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（158-159）----慢性胃炎病因

幽门螺杆菌（HP）

慢性胃炎约 90%由 HP 感染引起，幽门螺杆菌具有鞭毛，能穿过胃的黏液层到胃黏膜，通过其产氨作用、分泌空泡毒素 A 等物质引起细胞损害；其细胞毒素相关基因蛋白能引起炎症反应；幽门螺杆菌细胞壁可作为抗原诱导免疫反应。以上因素长期存在致使胃黏膜发生慢性炎症

自身免疫反应

胃体和胃底萎缩为主，壁细胞损伤刺激机体→壁细胞抗体→胃酸分泌↓和内因子↓→VB<sub>12</sub>吸收障碍→恶性贫血

## 2026 陶老师 500 考点预测（160-162）----慢性胃炎 消化性溃疡药物治疗

【陶老师巧记】奥林匹克运动会：“奥”-奥美拉唑“林”-阿莫西林“匹”-PPI“克”-克拉霉素

根除幽门螺杆菌

PPI+克拉霉素+阿莫西林  
PPI+克拉霉素+甲硝唑

根除率最高的，效果最好。一般的疗程是 1~2 周（7~14 天）

首选药物

质子泵抑制剂（PPI）

通过抑制 H<sup>+</sup>-K<sup>+</sup>-ATP 酶而减少胃酸分泌（4-6 周）

如 HP 阳性

四联抗 HP（2 种抗生素+铋剂+PPI），疗程 10~14 天

胃黏膜保护剂

铋剂：形成蛋白-铋复合物，保护胃黏膜，还可以辅助杀灭 HP 的作用



## 2026 陶老师 500 考点预测（163-164）----十二指肠溃疡 胃溃疡鉴别

|      | 十二指肠溃疡（DU）            | 胃溃疡（GU）                    |
|------|-----------------------|----------------------------|
| 发作   | 进餐后 1~3 小时，也常发生在午夜至凌晨 | 进食后 30~60 分钟               |
| 疼痛时间 | 饥饿痛或空腹痛，餐后 3~4 小时出现   | 进餐后 0.5~1 小时出现，持续 1~2 小时后逐 |



看书做题 1 天，不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
点击右下角微信联系陶老师

|    |                   |                  |
|----|-------------------|------------------|
|    |                   | 渐缓解              |
| 规律 | 疼痛—进食—缓解（饥饿痛）     | 进食—疼痛—缓解（饱餐痛）    |
| 因素 | 侵袭因素增强为主好发球部前壁或后壁 | 保护因素减弱为主好发胃窦、胃小弯 |

## 【陶老师巧记】

1. 十二指肠溃疡：①好发：球部 【陶老师巧记】十二点→钟表→球形；  
②疼痛特点：疼痛—进食—缓解（饥饿痛）【陶老师巧记】想想自己到了十二点是什么感觉，肯定是饿得胃不舒服
2. 胃溃疡：①好发：胃窦、胃小弯，最好发是胃窦部【陶老师巧记】转弯的地方是非多；  
②疼痛特点：进食—疼痛—缓解（饱餐痛）【陶老师巧记】想想吃撑了后的感觉



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（165-169）——消化性溃疡并发症

|      |                                                                                                                                                                 |                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 出血   | 消化性溃疡最常见的并发症，十二指肠溃疡比胃溃疡易发生。可表现为呕血与黑便（柏油样）                                                                                                                       | 暂禁食，止血（药物止血）             |
| 穿孔   | 十二指肠溃疡多发，主要表现为腹部剧痛和具有急性腹膜炎的体征，胃溃疡的游离穿孔多发生于小弯，主要表现为突发剧烈腹痛，刀割样疼痛，持续而加剧，先出现于上腹，继之逐步延及全腹，腹壁呈板样僵直，有压痛和反跳痛<br>消化性溃疡穿孔的诊断金标准：立位 X 线检查，膈下游离气体<br>【陶老师巧记】同在一个屋檐下，用一个鼻孔出气 | 禁食，胃肠减压                  |
| 幽门梗阻 | 频繁呕吐宿食，不含胆汁最突出的症状（呕吐，吐宿食，量大，不含胆汁，有腐败酸臭味）；呕吐后自觉胃部舒适<br>腹部检查：上腹胃型和蠕动波，可闻振水声<br>梗阻严重者→消瘦、脱水、电解质紊乱和低钾低氯碱中毒症状<br>【陶老师巧记】吃梗住了，吐了                                      | 禁食、胃肠减压，必须手术。（最常用胃大部切除术） |
| 癌变   | 少数胃溃疡发生癌变，十二指肠溃疡不会发生癌变。（疼痛不规律）                                                                                                                                  | 手术                       |



## 2026 陶老师 500 考点预测（170）——餐前服用药物

【陶老师巧记】啊！饭前多吃个砂糖桔，真是健胃又消食

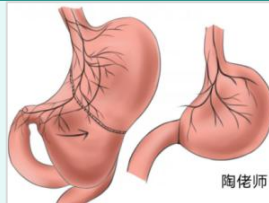
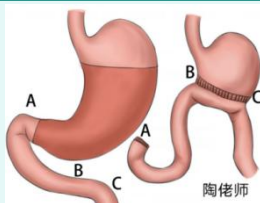
啊：阿奇霉素 多：多潘立酮 砂：莫沙必利 糖：硫糖铝 桔：枸橼酸铋钾 健胃又消食：健胃消食片

- 餐前服药：多潘立酮（吗丁啉）、莫沙必利、健胃消食片、枸橼酸铋钾、硫糖铝、阿奇霉素
- 抗酸药：餐后 1 小时服用
- 柳氮磺吡啶：餐后服用
- 硫酸亚铁：餐后服用，以减少胃肠道的反应
- 磺胺类药物：饭前半小时服用
- 阿卡波糖：与第一口饭一起服

## 2026 陶老师 500 考点预测（171-172）——消化性溃疡外科手术

|    |                 |                   |
|----|-----------------|-------------------|
| 分类 | Billroth I（毕 I） | Billroth II（毕 II） |
| 方式 | 胃残端与十二指肠吻合      | 将残胃与近端空肠吻合        |
| 图解 |                 |                   |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

|           |                                                                                   |                                                                                    |          |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|           |  |  |          |          |
| 十二指肠残端破裂  | 一般多发生在术后 24~48 小时                                                                 | 立即手术                                                                               |          |          |
| 胃肠吻合口破裂或瘘 | 多发生于术后 5~7 天<br>【陶老师巧记】我（5）吻（吻合口破裂）我的妻（7）子                                        | A. 吻合口破裂→立即手术修补；<br>B. 外瘘形成→引流、胃肠减压，必要时手术                                          |          |          |
| 胃大部切除术后梗阻 | 输入段                                                                               | 急性完全性                                                                              | 少量食物，无胆汁 | 紧急手术     |
|           | 梗阻                                                                                | 慢性不完全性                                                                             | 大量胆汁     | 不能缓解，再手术 |
|           | 吻合口梗阻                                                                             |                                                                                    | 食物，无胆汁   |          |
|           | 输出段梗阻                                                                             |                                                                                    | 食物和胆汁    |          |
|           | 【陶老师巧记】输入梗阻无胆汁，吻合梗阻无胆汁，输出梗阻混胆汁<br>完全吻合（我的胃口）无胆汁（好吃不苦），不全输出混胆汁                     |                                                                                    |          |          |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（173）——倾倒综合征

| 分类      | 原因                                                                                                | 临床表现                                                 | 预防方法                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 早期倾倒综合征 | 多发生于毕 I 式手术后，主要是由于胃大部切除术后丧失幽门括约肌的控制，导致食物排空过快，高渗食物快速进入空肠，将大量细胞外液吸入肠腔，使循环血量骤然减少，同时肠管膨胀、肠蠕动亢进、排空加速引起 | 进食 10~30 分钟后出现，上腹饱胀不适、恶心、呕吐、伴肠鸣和腹泻、心悸、大汗、头晕、乏力、面色苍白等 | 少食多餐，避免过甜、过咸、过浓、过浓流质，进食低糖类、高蛋白饮食，餐时限制饮水，进餐后平卧 20 分钟后可缓解 |
| 晚期倾倒综合征 | 进食后胃排空过快，含糖食物迅速进入小肠刺激胰岛素大量释放，继而发生反应性低血糖                                                           | 餐后 2~4 小时，患者出现心慌、无力、眩晕、出汗、手颤、嗜睡，也可导致虚脱               | 出现症状时稍进饮食，尤其是糖类即可缓解。饮食中减少糖类含量，增加蛋白质比例，少食多餐              |

【陶老师巧记】倾倒综合征：早期低血压，晚期低血糖  
起得真早呀（低血压），吃饭吃得晚，饿得我都（低血糖）了

## 2026 陶老师 500 考点预测（174-176）——大便性质记忆各种腹泻要点归纳

| 腹泻分型         | 发病特点                                    | 全身症状                      | 大便特点                             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 轮状病毒肠炎又称秋季腹泻 | 多发生在秋冬季节，以 6~24 个月婴幼儿为多                 | 常伴上感症状，感染中毒症状不明显，常伴脱水、酸中毒 | 黄色水样或蛋花汤样，含少量黏液，无腥臭味，几次到几十次/日，量多 |
|              | 【陶老师巧记】秋天到了，是收获的季节，开着车去装稻子，车子轮子是圆形像个鸡蛋， |                           |                                  |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

|                                                        |                                      |                            |                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 蛋花是无臭味的所以喜欢喝!                                          |                                      |                            |                                   |
| 侵袭性大肠杆菌肠炎                                              | 多见于气温较高季节                            | 恶心、呕吐、里急后重及全身中毒症状, 休克      | 腹泻频繁, 黏液脓血便, 有腥臭味                 |
| 生理性腹泻                                                  | 多见于6个月以下婴儿, 生后不久即腹泻, 不需特殊治疗, 不影响生长发育 | 外观虚胖, 常有湿疹, 精神、食欲好, 体重增长正常 | 除大便次数增多外, 无其他症状, 添加辅食后, 大便即逐渐转为正常 |
| 【陶老师巧记】除了拉肚子, 其他哪儿都好, 但还是注意有时题干里会出现什么湿疹、虚胖, 也是说的生理性腹泻。 |                                      |                            |                                   |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (177-179) ----脱水的严重程度

| 项目    | 轻度      | 中度     | 重度              | 【陶老师巧记】判断脱水<br>只需记住形容词<br>轻度脱水: 稍<br>中度脱水: 明显、较<br>重度脱水: 极、无、休克 |
|-------|---------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 失水占体重 | 3%~5%   | 5%~10% | >10%            |                                                                 |
| 精神状态  | 稍差, 略烦躁 | 烦躁或萎靡  | 昏睡、昏迷           |                                                                 |
| 皮肤弹性  | 稍差      | 差      | 极差              |                                                                 |
| 口腔黏膜  | 稍干燥     | 明显干燥   | 极干燥             |                                                                 |
| 眼窝及前囟 | 稍凹陷     | 明显凹陷   | 深(极度)凹陷, 眼睑不能闭合 |                                                                 |
| 眼泪    | 有       | 明显少    | 无               |                                                                 |
| 尿量    | 稍少      | 明显少    | 无               |                                                                 |
| 休克症状  | 无       | 无      | 有               |                                                                 |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (180) ----腹泻脱水性质

| 脱水性质  | 血清钠           | 扫码获取陶老师<br>免费题库、免费视频 |
|-------|---------------|----------------------|
| 低渗性脱水 | <130mmol/L    |                      |
| 等渗性脱水 | 130~150mmol/L |                      |
| 高渗性脱水 | ≥150mmol/L    |                      |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (181-185) ----肠梗阻

|              |                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 粘连性肠梗阻       | 常在腹腔内手术(最常见)                                                                                                                                                   |
| 机械性肠梗阻 (最常见) | 小肠扭转多见于青壮年, 常在饱食后剧烈运动时而发病, 表现为突发脐周剧烈绞痛; 老年人常见于长期便秘; 常牵涉至腰背痛, 极易发生绞窄性肠梗阻, 故应及时手术治疗<br>肠扭转<br>多见2岁以内儿童, 常突然发作剧烈阵发性腹痛, 伴有呕吐和果酱样血便, 腹部可扪及腊肠形肿块, X线: “杯口状”阴影<br>肠套叠 |
| 血运性肠梗阻       | 肠管血运障碍—绞窄性肠梗阻—腹膜炎<br>呕吐物和排泄物呈血性, 血性腹水                                                                                                                          |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (186-190) ----总结记忆阑尾炎分型

## 【陶老师巧记】:

单纯性阑尾炎→典型的转移性右下腹痛

化脓性阑尾炎→持续右下腹痛,局限性的腹膜炎(压痛、反跳痛、腹肌紧张),脓流出来了

坏疽穿孔性阑尾炎→疼痛突然加重,或者疼痛缓解一会又加重,腹膜炎范围增加

阑尾周围脓肿→右腹部可以摸到包块,脓包裹在里面,没出来

## 【陶老师巧记】: 通过你今天早上吃的肉包及今天学的知识 分别说出 下面包子分别是哪种阑尾炎



阑尾周围脓肿



化脓性阑尾炎



扫码获取陶老师

免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (191-195) ----肝功能失代偿期-肝功能减退

|                       |               |                                                                                             |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 肝<br>功<br>能<br>减<br>退 | 全身症状          | 消瘦乏力、皮肤干枯、面色黝黑(肝病面容)、夜盲(缺乏维生素A所致)                                                           |
|                       | 消化道           | 可伴有黄疸,有腹胀、恶心、呕吐,进食脂肪和蛋白质后易引起腹泻                                                              |
|                       | 出血<br>和<br>贫血 | 毛细血管脆性↑、VK缺乏、凝血因子合成↓(最主要)、PLT质量异常(脾亢)等有关→鼻\牙龈出血,凝血时间延长<br>【陶老师巧记】他的脾气暴躁,因此要K他,K的越久他越听话,K出血了 |
|                       | 内分泌<br>紊乱     | 肝对雌激素及醛固酮灭活作用减弱导致,雄激素↓→男性乳房发育;女性月经失调不孕等,肝掌(手掌大鱼际,小鱼际和指端腹侧部红斑)及蜘蛛痣(于上腔静脉引流区如面、肩、上胸部,其中面最多见)  |

## 【陶老师巧记】初夜治黄小姐多

初(出血,贫血)夜(夜盲)治(蜘蛛痣)黄(黄疸)小姐(雌激素)多。

## 2026 陶老师 500 考点预测 (196-200) ----肝功能失代偿期-门静脉高压

|                            |               |                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 门<br>静<br>脉<br>高<br>压<br>症 | 脾大<br>(最早出现)  | 脾亢→全血减少(表现为白细胞、血小板和红细胞计数减少)                                                                                          |
|                            | 侧支循环建<br>立和开放 | 上:食管胃底静脉曲张(最核心)特征性表现→破裂导致上消化道出血(呕血+黑便)通常不能自行止血<br>处理:最简单,立即采取三腔二囊管压迫止血,压迫食管胃底静脉,一般临时止血用→压迫24小时,放气10~20分钟再用,使用不超过3~4天 |
|                            |               | 中:腹壁静脉曲张,脐周静脉明显曲张呈水母头状,脐以下进入下腔静脉,脐以上进入上腔静脉【陶老师巧记】上上下下                                                                |
|                            |               | 下:痔静脉曲张,破裂时引起便血                                                                                                      |
|                            | 腹水            | 肝硬化失代偿期最突出的表现                                                                                                        |

看书做题1天,不如听课1小时

门静脉压力增高（最主因）；低蛋白血症；肝淋巴液生成过多；继发性醛固酮和抗利尿激素↑

腹水形成因素【陶老师巧记】全是鸭蛋零分

全：醛固酮、抗利尿激素灭活减少，继发性增多

鸭：门静脉压力高（腹水形成最主要因素）

蛋：白蛋白低（低于 30g/L 时），血浆胶体压下降

零：肝内静脉回流受阻，淋巴液生成多，经肝表面漏出



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

【陶老师巧记】门静脉高压症记忆口诀 三大临床表现：脾肿大，侧支循环的建立和开放，腹水

开门啦，开门（门静脉）啦，大（脾肿大）水（腹水）冲了龙王庙，冲成（侧支循环的形成）了上（食管胃底静脉曲张）中（腹壁静脉曲张）下（痔静脉）三条路！

“成”最特异。只有肝硬化有这个特点

## 2026 陶老师 500 考点预测（201）——肝硬化并发症

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 上消大出血 | 最常见并发症，多突然发生呕血和（或）黑便，引起出血性休克可诱发肝性脑病            |
| 感染    | 因机体抵抗力低下，并发感染，如自发性腹膜炎（多为革兰氏阴性菌感染）、肺炎、胆道感染及败血症等 |
| 肝性脑病  | 最严重的并发症，亦是最常见的死亡原因                             |
| 肝癌    | 多年之后发生，短期肝大+表面结节+血性腹水+肝区疼痛=肝癌                  |

## 2026 陶老师 500 考点预测（202-205）——肝性脑病分期

| 分期      | 症状                                                             | 体征                                           | 脑电图                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 一期 前驱期  | 轻度性格改变和行为失常                                                    | 可有扑翼样震颤                                      | 多数正常                            |
| 二期 昏迷前期 | 以意识错乱、睡眠障碍、行为异常为主（嗜睡）。定向力、理解力均减退，不能完成简单的计算和智力构图，言语不清、书写障碍、举止反常 | 可出现腱反射亢进、肌张力增高、踝阵挛及 Babinski 征（+），扑翼样震颤存在    | 有特征性改变<br>（典型：节律变慢，δ 波 3~7 次/秒） |
| 三期 昏睡期  | 以昏睡和精神错乱为主，可唤醒                                                 | 神经体征加重；扑翼样震颤仍可引出                             | 异常加重，δ 波更明显、频率低                 |
| 四期 昏迷期  | 神志完全丧失，不能唤醒                                                    | 浅昏迷：对痛刺激和不适体位尚有反应；<br>深昏迷：各种反射消失，瞳孔散大。扑翼样震颤无 | 明显异常，δ 波 1~3 次/秒                |

【陶老师巧记一】重点考二、三期

同时出现：意识错乱+腱反射亢进、肌张力+扑翼样震颤+脑电图改变

记忆：这个人很 2，“你个 2 货”——想象 2 的人什么样

注意：二、三期区分重点看病人昏睡时间，大部分时间在睡觉选择三期

【陶老师巧记二】关于肝性脑病分期口诀



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

一期性格有改变，黑白颠倒分不清；二期记成他很二，回答问题都是错  
三更半夜非常困，困得自己想睡觉；四和死字音相似，迷死一个算一个  
陶老师解释：二期以醒为主，回答问题错误；三期是昏睡，四是昏迷



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (206) ----意识障碍的记忆总结

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 可以喊醒 | 嗜睡：对答切题【陶老师巧记】天天睡得像猪一样，你肯定会说“你才是猪” |
|      | 昏睡：睡得昏天黑地，答非所问                     |
| 醒不来  | 意识模糊：不能喊醒，对刺激可躲避，出现幻觉              |
|      | 浅昏迷：不能喊醒，对刺激有痛苦表情【陶老师巧记】钱迷→掏钱好痛苦   |
|      | 深昏迷：无任何反应                          |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (207-210) ----肝性脑病治疗原则及护理措施

|              |                                                               |                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消除诱因         | 积极防治感染和上消化道出血，避免快速、大量排钾利尿和放腹水，纠正电解质和酸碱平衡紊乱。禁用镇静安眠药、麻醉药        |                                                                                                                                   |
| 促代谢<br>纠紊乱   | 降氨药                                                           | 谷氨酸钾或谷氨酸钠与游离氨结合形成谷氨酰胺，从而降低血氨                                                                                                      |
|              | 支链氨基酸                                                         | 可纠正氨基酸代谢的不平衡，抑制大脑中假神经递质的形成                                                                                                        |
| 减少肠内毒物的生成和吸收 | 饮食                                                            | 减少或临时停止蛋白质饮食                                                                                                                      |
|              | 灌肠或导泻                                                         | 清除肠内含氮物质或积血，保持大便通畅，可用生理盐水或弱酸性溶液灌肠，禁用肥皂水灌肠。对急性门体分流性脑病昏迷病人以 33.3%乳果糖 500ml 灌肠作为首选治疗                                                 |
|              | 抑制肠道细菌生长                                                      | ①口服抗生素，如甲硝唑、新霉素（从小剂量开始服用，因可引起听力和肾脏损害，用药不超过 1 个月，出现损害改用甲硝唑）等，抑制肠内细菌生长，促进乳酸杆菌繁殖，减少氨的形成和吸收；②口服乳果糖，乳果糖被结肠细菌分解成乳酸和乙酸（又名醋酸），降低 PH→减少氨吸收 |
| 饮食护理         | 限制蛋白质摄入，最好给予植物蛋白。显著腹水病人应限制钠、水量，限钠应 250mg/d，水入量一般为尿量加 1000ml/d |                                                                                                                                   |

### 【陶老师巧记】诱发肝性脑病的因素记忆（肝脑涂地）

肝脑（肝性脑病）涂（涂和液体有关：大量腹水、大量利尿（低钾性碱中毒）、消化道出血地（昏倒在地——镇静剂、安眠药）

## 2026 陶老师 500 考点预测 (211-212) ----急性胆囊炎

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 症状 | 中老年妇女+右上腹阵发性绞痛（本病的典型表现）+进食油腻食物，饱餐后或夜间发生+疼痛常放射至右肩部、肩胛部和背部                          |
| 体征 | 右上腹有压痛、反跳痛和肌紧张，可在右上腹触及肿大而有触痛的胆囊；Murphy 征阳性-墨菲征（深压胆囊区，嘱病人深吸气，可有触痛反应）【陶老师巧记】摸王菲，胆真大 |

### 【陶老师总结】第一看手的位置：脐上还是脐下，脐上是肝 脐下是阑尾

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
点击右下角微信联系陶老师

第二步骤：看手指→四个手指在肋骨下是摸肝；一个大拇指在肋骨下是摸胆囊。

## 2026 陶老师 500 考点预测 (213-215) ----胆石症临床表现



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Charcot (夏科) 三联症 | 腹痛、寒战高热、黄疸                  |
| Reynolds 五联征     | Charcot 三联症+休克+昏迷 (休克：感染导致) |

【陶老师巧记】Reynolds (雷诺) 五联征 飞虎队休克昏迷了：腹痛、寒战高热、黄疸、休克、昏迷

【陶老师巧记】夏科是个飞虎队队员 (F-腹痛；H-寒战、高热；D-黄疸)

一看到肝外胆管结石就要想到 Charcot (夏科) 三联症是个飞虎队队员，即腹痛、寒战高热和黄疸在夏科三联症中：腹痛、寒战高热、黄疸。注意排序！

最早出现的症状：腹痛-F，在最前；最晚出现的症状：黄疸-D，在最后

## 2026 陶老师 500 考点预测 (216) ----AOSC 治疗原则

紧急手术解除胆道梗阻并减压 (AOSC 梗阻先解除)

以切开减压并引流胆管、挽救生命为主要目的，

故手术应力求简单有效，胆总管探查+T 管引流



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (217-219) ----胰腺炎病因及诱因

|                  |                                                                                                         |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 胆石症              | 我国最常见病因，共同通道学说                                                                                          |  |
| 大量饮酒             | 国外最常见病因                                                                                                 |                                                                                       |
| 暴饮暴食             | 最常见诱因【陶老师巧记】你不要诱惑我，我要减肥                                                                                 |                                                                                       |
| 主要机制<br>(胰酶自我消化) | ①卵磷脂酶 A2→溶解细胞膜磷脂→胰腺坏死、溶血（细胞膜上有磷脂）<br>②弹力蛋白酶→溶解血管的弹力蛋白→出血、血栓（管子有弹性）<br>③胰脂肪酶→分解脂肪成脂肪酸，脂肪酸与钙离子结合成钙皂而使血钙降低 |                                                                                       |
| 药物               | 噻嗪类利尿剂，磺胺嘌呤，激素、四环素、磺胺                                                                                   |                                                                                       |

【陶老师巧记】秦始皇的小姨子很漂亮，他很激动。



## 2026 陶老师 500 考点预测 (220-225) ----胰腺炎临床表现

|              |                                                          |                                |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 主要表现和首发症状    |                                                          |                                |
| 腹痛           | 性质                                                       | 突然起病，刀割样痛、钝痛、钻痛或绞痛，呈持续性，可阵发性加剧 |
|              | 部位                                                       | 中上腹，向腰背部呈带状放射                  |
|              | 缓解                                                       | 弯腰抱膝位可缓解；不能为胃肠解痉药缓解，进食可加重      |
|              | 预后                                                       | 轻症 3~5 天即缓解；重症持续较长，可引起全腹痛      |
| 呕吐、呕<br>吐/腹胀 | 胰液及胰腺坏死物进入腹腔，导致肠麻痹 (禁用阿托品)，<br>频繁呕吐且呕吐后不缓解 (反射性呕吐及肠麻痹所致) |                                |
| 腹膜炎          | 腹膜炎越严重，腹胀越明显，排气、排便停止                                     |                                |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
点击右下角微信联系陶老师

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | ★水肿性胰腺炎（轻型、单纯水肿性胰腺炎）多局限于上腹部，常无肌紧张                                    |
|       | ★坏死性胰腺炎（重症胰腺炎）腹部压痛明显，伴肌紧张、反跳痛，肠鸣音减弱或消失                               |
|       | Grey-Turner 征：胰酶坏死组织及出血进入皮下，致两侧胁腹部（腰部）皮肤暗灰蓝色（青紫）                     |
|       | Cullen 征：脐周青紫，机制同 Grey-Turner 征                                      |
| 电解质紊乱 | 呕吐频繁病人可有代谢性碱中毒。出血坏死型者常有脱水和代谢性酸中毒，并常伴有低血钾、低血镁、低血钙。低钙血症引起手足抽搐，为预后不佳的表现 |

## 【陶老师巧记】

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Grey-Turner 征 | G→转弯的弯度很大，Turn→转弯<br>所以在转弯的地方出现青紫，正好在腰的位置，腰是腹部和背部的转弯地带 |
| Cullen 征      | ①谐音“裤轮”→男人裤腰带一圈的位置出现青紫<br>②小姨（胰腺炎）喜欢穿露肚脐的裤子            |



## 2026 陶老师 500 考点预测（226-230）——胰腺炎检查

| 指标   | 临床特点                                 | 意义                       |
|------|--------------------------------------|--------------------------|
| 血淀粉酶 | 6~12h 开始升高，24h 达到最高，48h 开始下降→持续 3~5d | 血淀粉酶 > 500u/dl，其高低与病情不平行 |
| 尿淀粉酶 | 24h 开始升高→1~2w 正常                     | 受尿量影响大                   |
| CRP  | 有助于评估与监测胰腺炎的严重性                      | 胰腺坏死时 CRP ↑              |
| 脂肪酶  | 24~72h 开始升高→持续 7~10d                 | 针对就诊晚患者有诊断价值             |
| 白细胞  | 多数升高                                 |                          |
| 血钙   | 降低                                   | 出血坏死型胰腺炎                 |
| 血糖   | 升高                                   |                          |



## 【陶老师巧记】

1. 血淀粉酶升高的临床特点：12h 开始升高，24 小时达到最高，48h 开始下降，持续 3~5d。

【陶老师巧记】“半天→1 天→2 天→3~5 天”（半 12345 天，这样就记住了）

2. 脂肪酶对就诊晚患者有诊断价值【陶老师巧记】吃完饭最后很久才转化成自己身上的肉（脂肪）

3. 做病例题思路：看好题目，如果题目说进食后几小时出现腹痛，那首选查血清淀粉酶；如果说 1~3 天出现腹痛，选择尿淀粉酶；如果 3 天后的，查的比较晚，选择脂肪酶。

扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（231-233）——胰腺炎治疗

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 抑制减少胰液分泌 | 禁食 胃肠减压：禁食 1~3 天，减少胃酸与食物刺激胰液分泌；胃肠减压，减轻呕吐腹胀             |
|          | 抑制胰液分泌 生长抑素或类似物（奥曲肽）常用于重症胰腺炎<br>奥曲肽还可降门静脉高压，主要就这 2 个作用 |
| 解痉镇痛     | 654-2+哌替啶，不可用吗啡（引起 Oddi 括约肌痉挛）                         |
|          | 不用阿托品（本来就肠麻痹，阿托品松弛平滑肌，更麻痹）                             |

## 【陶老师巧记】

急性胰腺炎镇痛不可用吗啡（引起 Oddi 括约肌痉挛）→记忆“妈啊，疼死我了！”

## 2026 陶老师 500 考点预测 (234-236) ----止血药物选择

|      |       |              |                                      |
|------|-------|--------------|--------------------------------------|
| 止血措施 | 药物治疗  | 去甲肾上腺素胃内灌注   | 胃、十二指肠出血                             |
|      |       | 垂体后叶素        | 食管静脉曲张破裂出血，对消化性溃疡，急性胃黏膜损害出血，冠心病及孕妇禁用 |
|      |       | 抑酸药          | 急性胃黏膜损害及消化性溃疡出血                      |
|      |       | 生长抑素         | 食管胃底静脉曲张出血首选                         |
|      | 气囊管压迫 | 用于食管胃底静脉曲张出血 |                                      |

## 【陶老师巧记】——止血总结记忆

胃出血——抑酸药 (XX 拉唑) ——胃镜 (首选) ——手术  
 肝出血——生长抑素——三腔二囊管 (首选) ——介入手术  
 肺出血——垂体后叶素——气管镜



## 2026 陶老师 500 考点预测 (237) ----出血病人饮食三部曲

【陶老师巧记】出血病人饮食三部曲：①大出血→暂禁食；②少量出血无呕吐无明显活动性出血→温凉、清淡无刺激性流食；③不出血→易消化的半流食、软食，开始少量多餐

## 2026 陶老师 500 考点预测 (238) ----急腹症四禁

【陶老师总结】①急腹症的“四禁”即禁食 禁用止痛药 禁灌肠 禁服泻药；②急腹症患者需禁食，常需要胃肠减压；③急腹症患者的症状和体征有时虽表现在局部，但不可忽视患者的特殊情况

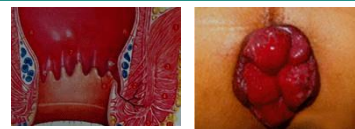
## 2026 陶老师 500 考点预测 (239) ----异常粪便

暗红色便→下消化道出血  
 柏油样便→上消化道出血  
 粪便表面有鲜血→痔疮和肛裂  
 白陶土样便→胆道梗阻  
 果酱样便→肠套叠、阿米巴痢疾  
 白色“米泔水”样便→霍乱、副霍乱  
 粘液脓血便→细菌性痢疾、溃疡性结肠炎



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (240-241) ----内痔 外痔



| 分类 | 特点                                               |
|----|--------------------------------------------------|
| 内痔 | 位于齿状线以上，表面覆盖直肠黏膜，好发于直肠下端的左侧、右前或右后方（截石位 3、7、11 点） |
| 外痔 | 位于齿状线下方，表面覆盖肛管皮肤                                 |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (242-243) ----痔疮分期



|      |                    |       |                               |
|------|--------------------|-------|-------------------------------|
| 临床表现 | 内痔<br>(无痛+出血+痔块脱出) | I 期   | 排便时无痛性出血+痔块不脱出                |
|      |                    | II 期  | 便血加重, 严重时呈喷射状+痔块能出能进          |
|      |                    | III 期 | 便血量常减少+痔块能出不能进 (需手托回)         |
|      |                    | IV 期  | 痔块长期脱出于肛门外或回纳后又即脱出            |
|      | 外痔                 | 一般    | 肛门不适、潮湿+局部瘙痒                  |
|      |                    | 血栓性   | 肛门剧痛, 排便、咳嗽时加剧+肛门表面可见红色或暗红色硬结 |

【陶老师巧记】I 期块不突, II 期能进能出 (II 对应 2 记忆有两种选择所以能进能出)

III 期能出不进, 必须用手托回去 (想想和小三见面只能出去见, 不能带进家)

IV 期死 (4) 的心都有了, 就什么不顾了, 长期不回家, 喊也不回家

## 2026 陶老师 500 考点预测 (244-246) ---甲亢诊断

| 项目          | 意义                                                           | 备注                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 基础代谢率 (BMR) | $BMR\% = \text{脉压} + \text{脉率} - 111$<br>禁食 12h、睡眠 > 8h、静卧空腹 | 正常值 -10% ~ +10%, 20% ~ 30% 轻度甲亢, 30% ~ 60% 中度甲亢, 60% 以上为重度甲亢 |
| FT3、FT4     | 诊断甲亢首选检查                                                     | 甲亢升高                                                         |
| 促甲状腺激素      | TSH 反应甲亢最敏感指标                                                | 甲亢时降低                                                        |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (247-248) ---甲状腺危象表现及处理

|    |                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 机制 | 即甲亢症状加重, 可能与交感神经兴奋, 大量 $T_3$ 、 $T_4$ 释放入血等有关                                                                                                 |
| 诱因 | 应激、感染、 $^{131}I$ 治疗反应、手术准备不充分等                                                                                                               |
| 表现 | ①体温 $\geq 39^\circ C$ ; ②心率 $\geq 140$ 次/分; ③恶心、厌食、呕吐、腹泻、大汗、休克;<br>④神情焦虑、烦躁、嗜睡或谵妄、昏迷; ⑤可合并心衰、肺水肿等<br>【陶老师巧记】甲亢病人出现高热、心率快、大汗、休克、昏迷-说明很危险---甲危 |
| 处理 | ①首选丙硫氧嘧啶抑制甲状腺激素的释放入血 【陶老师巧记】甲乙丙<br>②吸氧 ③安静休息                                                                                                 |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (249-252) ---甲亢术后并发症

|     |         |                       |                                                                                          |
|-----|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 并发症 | 呼吸困难和窒息 | 最危急的并发症<br>(术后 24 小时) | 拆除缝线, 敞开伤口, 去除血肿                                                                         |
|     | 喉返神经损伤  | 单侧声音嘶哑; 双侧: 失声、窒息     | 单侧: 术后可由健侧声带向病侧过度内收而恢复发声<br>神经营养药、理疗、禁声及短期激素治疗。暂时性损伤, 一般 3-6 月可恢复; 一侧永久损伤可代偿; 双侧损伤应作气管切开 |
|     | 喉上神经损伤  | 内支-呛咳, 误咽外支-声调变低      |                                                                                          |
|     | 手足抽搐    | 损伤甲状旁腺所致 (低钙)         | 补充钙剂、维生素 D, 发作时立即静注 10% 葡萄糖酸钙 10~20ml 限制肉类、乳品、蛋类等                                        |

|                       |              |                                                   |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 甲状腺危象（只是很危险的现象，不是最严重） | 预防关键在于充分术前准备 | ①安静休息②吸氧③抑制甲状腺素的释放④降低周围组织对儿茶酚胺的反应⑤调节应激反应⑥协助控制原发诱因 |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|

## 2026 陶老师 500 考点预测（253-254）——糖尿病急性并发症

|              | 机制                                                           | 临床表现                                       | 血糖                                 | 治疗                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 糖尿病酮症酸中毒     | <b>I 型糖尿病</b> 最常见；代谢紊乱加重时，脂肪分解加速，产生大量酮体 <b>乙酰乙酸、β 羟丁酸、丙酮</b> | 呼吸深大（ <b>Kussmaul 呼吸</b> ）呼气中有 <b>烂苹果味</b> | 16.7-33.3mmol/L 酮体阳性               | 大量补液；先快后慢；小剂量胰岛素持续泵；纠正电解质及酸碱平衡失调；见尿补钾。 |
| 高渗性非酮症性糖尿病昏迷 | 多数患者无糖尿病史或仅有轻度糖尿病症状                                          | 多尿、多饮，但多食不明显以后失水情况逐步加重逐渐出现神经精神症状           | 33.3-66.6mmol/L 尿糖强阳性，但 <b>无酮症</b> | 与糖尿病酮症酸中毒治疗原则基本相同                      |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（255-257）——糖尿病药物治疗

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 降糖药   | <p>1、抑制肝糖原输出→双胍类；<b>2 型肥胖糖尿病首选</b>；最常见副作用→消化道反应；</p> <p>2、促进胰岛素分泌→<b>磺脲类</b>：（时刻刺激分泌）最常见不良反应→<b>最容易导致低血糖</b>。适合于餐后血糖高的 2 型糖尿病</p> <p>3、促进胰岛素分泌→格列奈类（早时相分泌）</p> <p><b>4、延缓肠道对糖的吸收→α 葡萄糖苷酶抑制剂，用于餐后血糖高的 2 型胖子糖尿病</b>；最常见→胃肠道反应。</p> <p>5、增加组织对胰岛素敏感性→噻唑烷二酮类（罗格列酮）胰岛素抵抗明显的 2 型糖尿病 不良反应主要是水肿心脏毒性心力衰竭禁用。【陶老师巧记】心塞</p> <p>【陶老师巧记】降糖药服用方法：①双胍类：进餐时或进餐后服②磺脲类：饭前半小时口服③α 葡萄糖苷酶抑制剂：与第一口饭同时嚼服</p> <p>6、胰岛素适应症【陶老师巧记口诀】1 型糖尿病控制不佳并发感染；手术分娩后体重急剧下降</p> <p>①1 型糖尿病、②药物控制不佳、③急慢性并发症④体重急剧下降者、⑤手术（手术）、⑥妊娠分娩（生娃）</p> |
| 降糖药巧记 | <p>【陶老师选药巧记】：胖子吃瓜（二甲双胍），餐后吃糖（阿波卡糖）→胖子都是“吃”</p> <p>瘦子喝尿（磺脲类），餐后喝奶（格列奈类）→瘦子都是“喝”</p> <p>如果反抗（胰岛素抵抗）一起同（格列酮）归于尽</p> <p>【陶老师降糖药物副作用总结】：吃瓜（双胍类）吃糖（α-葡萄糖苷酶抑制剂）容易引起消化道症状喝尿（磺脲类药物）喝奶（格列奈类）容易引起低血糖<b>口服降糖药，一般孕妇禁用，可以导致孩子低血糖，孕妇降血糖都是胰岛素。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2026 陶老师 500 考点预测（258-260）——维生素 D 缺乏佝偻病临床表现

|   |                |
|---|----------------|
| 初 | ▽症状：闹、惊、汗、痒、秃； |
|---|----------------|

|    |                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期  | ▽体征： <b>枕秃(+) 无骨骼改变</b><br>▽辅助检查：X 线正常或钙化带稍模糊 25-(OH)D <sub>3</sub> 下降血钙正常或稍低、血磷降低                                  |
| 激期 | 3~6 个月—— <b>颅骨软化</b> 7~8 个月—— <b>方颅</b><br>6 个月以上四肢—— <b>手镯、脚镯</b><br>1 岁左右—— <b>胸廓——肋骨串珠、肋膈沟、赫氏沟、鸡胸/漏斗胸 X/O 形腿</b> |

【陶老师巧记】初期：易激惹，枕秃，睡眠不安；激期：颅骨软化的方颅娃娃，玩着串珠样手足镯子

## 2026 陶老师 500 考点预测 (261-263) ——维生素 D 缺乏低钙抽搐处理



|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 急救处理       | ①吸氧；② <b>迅速控制惊厥和喉痉挛——苯巴比妥、水合醛酸、地西泮</b>                                                     |
| 钙剂治疗尽快给予钙剂 | 10%葡萄糖酸钙 5~10ml 加入 10%~25%葡萄糖 10~20ml 中静滴，每日 2~3 次，至惊厥停止，然后改口服。 <b>治疗步骤：先解痉--再补钙--再补 D</b> |
| 维生素 D 治疗   | 同维生素 D 缺乏                                                                                  |

【陶老师巧记】：维生素 D 缺乏性搐搦症发作时，首要的治疗措施是镇静止痉，其次给予钙剂和维生素 D 治疗。

## 2026 陶老师 500 考点预测 (264-265) ——缺铁性贫血补铁方法



|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 饮食护理 | 合理饮食、补铁、母乳喂养、添加含铁辅食或补充铁强化食品； <b>对早产儿和低体重儿自 2 个月左右给予铁剂。</b>                                                  |
| 铁剂应用 | ①在饭后或两餐之间服用（成人为餐后，小儿为两餐中间）从小剂量开始；②用吸管或服药后漱口，避免染黑牙齿；③与维生素 C、果汁同服，以利吸收；④服铁剂同时 <b>忌饮茶、牛奶、咖啡</b> ；⑤ <b>大便变黑</b> |
| 监测指标 | 补铁后网织红首升高，HB 正常后，继续铁剂 4-6 个月                                                                                |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (266) ——蚕豆病

|      |                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概述   | <b>蚕豆病是一种遗传性疾病，因为身体里缺乏一种叫 G6PD 的酶。</b> 如果吃了蚕豆或某些药物，红细胞容易被破坏，就会引发溶血，出现黄疸、贫血等症状。治疗上首先要避免接触诱因，比如不吃蚕豆、不用禁忌药物。如果发病了，要及时就医，可能需要输血、补液，严重时用激素治疗。                                                                  |
| 发病机制 | G6PD 是一种酶，就像身体里的“小卫士”，能保护红细胞不被破坏。如果这种酶缺乏了，红细胞就会变得很脆弱，遇到蚕豆、某些药物等“敌人”时，就容易破裂引发问题。简单说，它是维持红细胞健康的重要“帮手”。<br><b>因为蚕豆里含有一些氧化物质，正常情况下，G6PD 酶能“中和”这些物质保护红细胞。</b> 但蚕豆病患者缺乏这种酶，红细胞遇到这些氧化物质就像没穿“防护衣”，容易被破坏破裂，从而引发溶血。 |
| 禁忌   | 阿司匹林、乙酰氨基酚不能用。                                                                                                                                                                                            |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (267) ——巨幼细胞性贫血记忆

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 摄入不足 | 因羊乳中维生素 B <sub>12</sub> 和叶酸含量少，未及时添加辅食，可引起 <b>维生素 B<sub>12</sub>和叶酸缺乏。</b> |
|------|----------------------------------------------------------------------------|

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 一般表现 | 多虚胖，毛发稀疏细黄，面色苍黄或蜡黄，口唇、指甲等处苍白，常伴肝、脾肿大                                       |
| 神经系统 | 患儿烦躁、易怒、妄想。维生素 B <sub>12</sub> 缺乏者表情呆滞、目光发直、少哭不笑、反应迟钝、嗜睡，智力及动作发育落后，常有倒退现象。 |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (268-270) ——再生障碍性贫血

|        |    |                                                                                                               |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病因     | 药物 | 氯霉素（最常见）、磺胺药、保泰松、苯妥英钠；<br>【陶老师巧记】你这笨（苯）男人有障碍，容易被绿（氯霉素）啊<br>【陶老师巧记】男人障碍了，抬不起头（血常规啥都低）就容易被戴绿帽子（氯霉素）<br>治疗障碍用雄激素 |
| 雄激素    | 安雄 | 慢性再障首选药物-丙酸睾酮、司坦唑醇等                                                                                           |
| 制定活动计划 |    | 重度以上贫血（血红蛋白<60g/L）——卧床休息；中度——休息活动交替                                                                           |
| 药物护理   |    | 注意雄激素副作用及护理：①该药为油剂，需深层注射；由于吸收慢，注射部位易发生肿块，要经常检查注射部位，发现硬块要及时理疗；②男性化；停药后短期内会全部消失；③肝功能受损，用药定期检查肝功能。               |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (271-274) ——过敏性紫癜

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 单纯型（紫癜型） | 最常见。反复皮肤紫癜为主要表现，多位于下肢及臀部，呈对称分布，分批出现，大小不等，经 7-14 天消退。  |
| 腹型       | 腹痛呈阵发性绞痛或持续性钝痛，多位于脐周或下腹部，发作时可因腹肌紧张、明显压痛及肠鸣音亢进而误诊为急腹症。 |
| 关节型      | 关节部位血管受累→关节肿胀、疼痛、压痛及功能障碍。多于膝、踝、肘、腕等大关节。               |
| 肾型       | 紫癜后 1 周出现蛋白尿、血尿、管型尿。严重者可发展为慢性肾炎。                      |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (275-278) ——急性肾小球肾炎临床表现

|     |                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蛋白尿 | 本病必有表现，尿蛋白量常在 1~3g/d                                                                               |
| 血尿  | 多镜下血尿，也出现肉眼血尿及管型尿。<br>【陶老师对比记忆】红细胞>3 个/HP 为异常、白细胞>5 个/HP 为异常<br>【陶老师巧记】红（red 3 个字母），白（white 5 个字母） |
| 水肿  | 多眼睑、颜面水肿和（或）双下肢水肿（轻中度）                                                                             |
| 高血压 | 严重血压高→高脑病、高心病及高血压，危象中度以上的高血压→肾功恶化较快，预后差<br>【陶老师巧记法】盐鸭蛋吃多了，很咸，猛喝水，第二天起来眼睛肿的很高，需要去验血查原因              |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (279-282) ——急性肾小球肾炎护理

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 总原则  | 卧床休息+对症治疗为主                                        |
| 卧床休息 | 卧床休息 4~6 周，待肉眼血尿消失，BP 正常，水肿消退再增加活动；3 个月内宜避免剧烈体力活动。 |

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 休息 | 避免劳累：尿蛋白不多、水肿不明显、无严重高血压及肾功损害可从事轻工作                                    |
| 饮食 | 总原则：高糖、高维生素、适量（低）蛋白质和脂肪的低盐饮食<br>急性期：1~2 周内，控制钠摄入，每日 1~2g，水肿消退后每日 3~5g |

## 2026 陶老师 500 考点预测（283）——小儿急性肾小球肾炎护理措施

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 2 周内                                               | 绝对卧床休息       |
| 待水肿消退、血压降至正常、肉眼血尿消失后                               | 可下床轻微活动或户外散步 |
| 1~2 个月                                             | 活动量宜加限制      |
| 3 个月内                                              | 避免剧烈活动       |
| 尿内红细胞减少、血沉正常                                       | 可上学需避免体育活动   |
| Addis 计数正常                                         | 正常生活         |
| 【陶老师巧记】：<br>2 周内绝对卧床，症状消失可下床，血沉正常可上学；Addis 计数正常可活动 |              |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（284-286）——肾病综合征临床表现

| 表现    | 特点                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蛋白尿   | 大量蛋白尿（+++~++++），24h 尿蛋白定量>3.5g                                                                        |
| 低蛋白血症 | 血浆白蛋白低于 30g/L                                                                                         |
| 水肿    | 最常见症状，水肿常随体位而改变，晨起眼睑、头枕及腰骶部水肿显著→起床后下肢为主，呈可凹性【陶老师解释】血液中的白蛋白低了白蛋白有锁住血管水分能力（胶体压）白蛋白低了就锁不住水分了水就流到组织中，造成水肿 |
| 高脂血症  | 胆固醇增多导致，胆固醇>5.6【陶老师解释】低蛋白血症刺激肝脏合成脂蛋白增多                                                                |

## 2026 陶老师 500 考点预测（287）——肾病综合征病人治疗

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 休息        | 严重水肿、体腔积液时需要卧床休息                                                                    |
| 饮食        | 高生物效价优质蛋白饮食，热量充分保证，水肿时低盐（<3g/d）                                                     |
| 利尿消肿      | 必要时使用                                                                               |
| 减少尿蛋白     | ACEI 及 ARB→肾小球高压↓→尿蛋白排泄↓→延缓肾功损害                                                     |
| 抑制免疫及炎症反应 | 激素(首选)。用药原则：起始量足+撤药要慢+用药要久：一般为 6~8 周（短期治疗有效者，亦应坚持此期限），必要时可延长到 12 周。短期治疗无效也要坚持到这个时间！ |

## 2026 陶老师 500 考点预测（288-290）——慢性肾衰竭

|    |                                                                    |                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 饮食 | 优质低蛋白质+高热量+多种维生素+低磷高钙+限盐。液体入量=前 1 天出液量+隐性失水 500ml，尿量>1000ml/d，不限水。 |                                           |
| 对症 | 高血压                                                                | 利尿，ACEI（首选）                               |
| 治疗 | 并发症                                                                | 控制感染避免肾毒性药，纠正水、电解质、酸碱平衡失调；贫血（促红细胞生成素 EPO） |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (291) --- 饮食护理总结

|                                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 各系统饮食总结                                                                            | <b>循环系统:</b> 三低--低热量、低脂、低盐 (高血压、冠心病)                               |
|                                                                                    | <b>呼吸系统:</b> 三高--高热量、高蛋白、高维生素 (肺炎发热的病人); 肺心病和循环系统一样                |
|                                                                                    | <b>消化系统:</b> ①腹泻-少渣饮食②便秘-多吃水果、蔬菜、高纤维③胆道/胰腺--低脂饮食④肝硬化-高蛋白⑤肝性脑病-限制蛋白 |
|                                                                                    | <b>泌尿系统:</b> 除了肾病综合征高生物效价优质蛋白饮食, 其余多为优质低蛋白, 动物蛋白为主。                |
| 饮食总结                                                                               | <b>高蛋白饮食:</b> 高代谢性疾病如结核病、低蛋白血症                                     |
|                                                                                    | <b>低脂肪饮食:</b> 肝、胆、胰                                                |
|                                                                                    | <b>低盐饮食:</b> 慢性肾炎、心脏病、肝硬化腹水、重度高血压但水肿较轻病人                           |
|                                                                                    | <b>无盐低钠:</b> 同低盐, 水肿严重                                             |
|                                                                                    | <b>少渣饮食:</b> 伤寒、痢疾、腹泻、肠炎、食管胃底静脉曲张                                  |
|                                                                                    | <b>低胆固醇:</b> 高胆固醇血症、动脉粥样硬化、冠心病                                     |
| 禁食                                                                                 | <b>禁食疾病:</b> 急性胰腺炎、急腹症、腹部损伤、大咯血、大呕血、肠梗阻                            |
| <b>陶老师限盐巧记口诀:</b><br>高血压<6g (高乐高) - 心衰<5g (我很衰) - 肝硬化、肾衰<2g 肝性脑病 (限钠) <250mg (二百五) |                                                                    |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (292-295) --- 急性肾衰竭

|     |                    |                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 少尿期 | 少(无)尿              | 持续 1~2 周, 少尿<400ml/d, 无尿<100ml/d                                                                                                                            |
|     | 水电解质<br>酸碱平衡<br>失调 | ①水↑→心衰(主要死因之一)、肺水肿、脑水肿; ②高钾血症(最严重并发症, 起病第 1 周最常见死因)→心律失常, 重者心室颤动、心脏骤停; ③代酸、高磷、高镁、低钙、低钠、低氯血症等<br><b>【陶老师巧记】</b> 霍元甲和宋美龄喝高了, 尿不出来。<br>贾玲又高又美→高钾、高磷、高镁, 剩下的都是低 |
|     | 多尿期                | 尿量增加 每日尿量超过 400ml, 是肾功开始恢复标志                                                                                                                                |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (296-298) --- 总结记忆各种管型尿

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 总结记忆各种管型尿 | <b>【陶老师巧记】</b> 红球白鱼那样衰, 死皮赖脸脂肪真(综)厚                           |
|           | 红细胞管型→肾小球疾病, 白细胞管型→肾盂(鱼)肾炎<br>那样(蜡样)→肾衰 肾小管坏死→上皮管型 脂肪管型→肾病综合征 |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (299) --- 酸碱中毒巧记

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 酸碱中毒巧记 | <b>陶老师巧记总结:</b> 酸碱中毒分为呼吸性和代谢性                                              |
|        | <b>1.呼吸性是肺部酸碱中毒问题:</b> 呼酸的表现是呼吸深大---CO <sub>2</sub> 潴留, 呼碱的表现呼吸表浅、快--过度通气。 |
|        | <b>2.代谢性是胃、肠、肾的问题:</b>                                                     |
|        | <b>胃:</b> 呕吐: 吐的捡起来 碱中毒<br><b>肠:</b> 腹泻 拉 拉的就算了 酸中毒                        |

看书做题 1 天, 不如听课 1 小时

**肾：**代酸的表现是高钾/代碱的表现低钾，碱中毒

注意：所有的重症疾病往往有代谢和呼吸的问题；两个都有问题：呼酸合并代酸；PH 值：酸中毒 <7.35；碱中毒 >7.45

## 2026 陶老师 500 考点预测（300-302）---尿路感染

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 致病菌    | 大肠埃希菌最为多见                               |
| 感染途径   | 上行感染是最常见的感染途径                           |
| 膀胱炎    | 占尿感 60%，表现尿频、尿急、尿痛（膀胱刺激征）+耻骨弓不适+无全身感染   |
| 急性肾盂肾炎 | 起病急+畏寒、高热（可达 40℃）+膀胱刺激征+肾区叩击痛+下腹部不适+管型尿 |

## 2026 陶老师 500 考点预测（303-304）---尿道损伤

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 好发人群 | 多见于男性                                                |
| 病变分类 | 前尿道：球部和阴茎体部，损伤以球部多见--骑跨伤<br>后尿道：前列腺和膜部，损伤以膜部多见--骨盆骨折 |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（305-306）---前列腺增生

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 尿频      | 前列腺增生病人最初出现的症状,早期仅表现夜尿增多，随后白天也尿频 |
| 进行性排尿困难 | 前列腺增生病人的典型表现症状（排尿迟缓、断续、尿后滴沥）     |

## 2026 陶老师 500 考点预测（307-310）---总结各种阴道炎

| 鉴别要点 | 滴虫阴道炎                   | 假丝酵母菌病               | 老年性阴道炎                   | 细菌性阴道病                    |
|------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 病因   | 阴道毛滴虫                   | 假丝酵母菌                | 雌激素下降，阴道防御力降低致病菌入侵繁殖     | 阴道内菌群失调乳杆菌减少厌氧菌繁殖         |
| 传播途径 | 直接和间接传染                 | 自身直接及间接              | 自身传染                     | 自身直接及间接                   |
| 临床表现 | 白带量多,稀薄泡沫状及外阴瘙痒         | 外阴瘙痒灼痛白带呈白色凝乳块状或豆渣样  | 白带增多及外阴瘙痒白带稀薄淡黄色或血样脓性    | 白带增多伴轻微瘙痒、白带灰白、均质、稀薄、鱼腥臭味 |
| 防治   | 酸性溶液冲洗阴道甲硝唑全身局部同时用药夫妻同治 | 碱性溶液冲洗祛除易感因素抗真菌药阴道给药 | 酸性溶液冲洗小剂量雌激素甲硝唑、氧氟沙星阴道给药 | 酸性溶液冲洗甲硝唑全身局部同时用药         |

### 陶老师对各种阴道炎最后总结 3 句话

①除了假丝酵母菌阴道炎→首选碳酸氢钠灌洗和抗真菌药物治疗→其他的都用弱醋酸溶液灌洗，首选甲硝唑治疗

②除了老年性阴道炎，其他的阴道炎→都需要夫妻同治；

③只有老年性阴道炎是自身感染→其他的都是外界传播

## 2026 陶老师 500 考点预测 (311-315) --- 子宫出血原因体温判断

## 陶老师总结--子宫出血原因体温判断

1.正常排卵，低温期与高温期明显(体温高于 36.5 至少 12-14 天)

2.无排卵，持续低温---单相型体温

女性卵巢功能异常，发育不良，无排卵，也没黄体形成，也就没有孕酮影响体温调节中枢，基础体温不会升高，体温持续低温

【陶老师巧记】一个月体温全部低于 36.5 度，没有升高

3.黄体功能不足，体温突然下降，高温不足 12 天，多是黄体功能维持时间不足

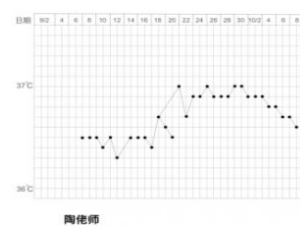
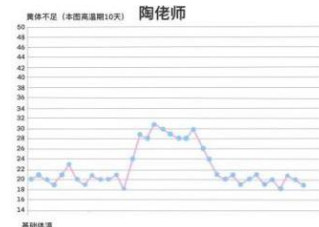
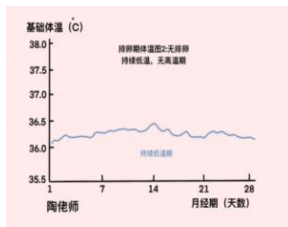
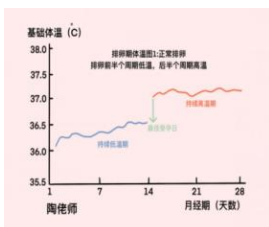
【陶老师巧记】高于 36.5 度不足 12 天，体温突然迅速下降

4.子宫内膜不规则脱落（黄体萎缩不全）：体温突然下降，高温不足 12

【陶老师巧记】高于 36.5 度不足 12 天，秋天到了体温慢慢下降，像落叶一样一片一片往下掉



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频



## 2026 陶老师 500 考点预测 (316-320) --- 子宫脱垂分度

|       |               |                        |
|-------|---------------|------------------------|
| I 度   | 轻型            | 宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，未达处女膜缘 |
|       | 重型            | 宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈      |
| II 度  | 轻型            | 宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内        |
|       | 重型            | 宫颈及部分宫体脱出阴道口           |
| III 度 | 宫颈与宫体全部脱出阴道口外 |                        |



【陶老师巧记】I 度重达处女膜, II 度重达部分宫体阴道外, III 度阴道外

I 度--一个人--处女 mo 还在--嗯哼 II 度--像口--阴道口--部分出来重度 III 度 --小三--肯定都在外面放着

## 2026 年陶老师主管初级护资 500 考点 考前最后一搏预测【25】小时=199 元

1. 一点都没有学的：只刷题的，停止刷题，听课还有希望

2. 没有完全学明白的：刷了很多题了，停止刷题，听课还有希望

3. 学的一般的：边学边刷题的听课

4. 学的很好的：也刷了很多题了，停止刷题，补缺补漏锦上添花



可以让你提高 10-30 分的网课 可以让你提分的巧记

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

**主管初级护资【考前 500 考点视频】时间安排:**

1. 内外妇儿 500 考点预测 **【22】** 小时 (提供电子版讲义)
  2. 中医基础知识讲解 **【3】** 小时 (提供视频)
- (4 月 7-10 号更新完毕, 7 号中午 12 点更新, 一直看到考试结束)

**版权声明**

本课程已向国家版权局申请版权

本课程未经授权不得以任何形式分享、共享、转载、转卖给任何第三方。  
第三方指除了学生本人之外的任何人, 包括你的至爱亲朋、手足兄弟。

已和专业律师事务所深度合作, 由专人进行市场监督。

本公司近期累计起诉 8 起盗版案例, 全部胜诉。

特此声明, 违者一定追究法律责任



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

**2026 陶老师 500 考点预测 (321-324) ---颈椎病分型**

| 类型 | 神经根型                                                             | 脊髓型                                                                                       | 椎动脉型                                                                           | 交感神经型                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 发病 | 最常见, 50~60%                                                      | 占 10%~15%                                                                                 | -                                                                              | -                                                                |
| 临表 | 牵拉神经根→颈、肩部疼痛, 可向上肢放射, 颈部僵硬, 上肢麻木<br><b>【陶老师巧记】</b> 神在天上--神经根--上肢 | 症状最重, 手部麻木不灵, 下肢麻木不稳, 踩棉花感。<br>Hoffmann 征、Babinski 征(+)<br><b>【陶老师巧记】</b> 脊-鸡在地下跑一下肢不稳、麻木 | 椎动脉压迫和刺激→基底动脉供血不足→ <b>眩晕, 头痛, 突然摔倒, 视觉障碍, 耳鸣, 听力下降</b><br><b>【陶老师巧记】</b> 一动就头晕 | 客观体征少, 呈神经症的表现 (面部和躯干麻木, 痛觉迟钝; 失眠减退等)<br><b>【陶老师巧记】</b> 焦虑就出汗、恶心 |

**【陶老师巧记】**

神经根型颈肩痛, 牵拉压头皆阳性。**【陶老师巧记】**一个人牵拉个鸭头, 神经病; 手足无力束带感, 病理阳性脊髓型。椎动脉型常猝倒, 体位诱发看不清。唯交感型最复杂, 痛麻汗燥心失常。



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

**2026 陶老师 500 考点预测 (325) ---术后早期下床总结**

陶老师总结术后早期下床

- ①下肢静脉曲张--防止血栓形成 ②阑尾炎、肠梗阻--防止肠粘连 ③腰椎间盘突出-防止神经根粘连

## 2026 陶老师 500 考点预测 (326-327) --- 腰椎间盘突出临床表现

|                                                                                                                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 腰痛及坐骨神经痛                                                                                                                                                               | 呈腰痛→坐骨神经痛（下腰部→臀部→大腿后方、小腿外侧→足背/外侧放射痛）<br>最先出现的症状 |
| 马尾神经受压综合征                                                                                                                                                              | 大小便障碍、双下肢疼痛、会阴麻木等【陶老师巧记：强拉马的尾巴，马的大小便失禁】         |
| 临床表现：好发部位：多见于腰 4~5，其次为腰 5~骶 1 间隙。<br>【陶老师巧记】妈呀，我的腰呀，疼死我了，因为活动度大                                                                                                        |                                                 |
|   |                                                 |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (328-330) --- 风湿热临床表现

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| 典型临床表现                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 发热   | 多数病人发热，高热多见儿童（最常见、最主要）          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 关节炎  | 占病例 66%，呈游走性、多发性，膝、踝、肘、腕、肩大关节常见 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 心脏炎  | 心悸+气短+心前区不适+杂音（最严重）             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 环形红斑 | 淡红色、多躯干、肢体近端分布，压之褪色             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 皮下结节 | 常在心脏炎时出现，无红肿、痛小结节               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 舞蹈病  | 儿童多发，风湿热后期出现                    |
| 【陶老师巧记】主要表现：五环星光下，迎风飘扬；风一吹，漫天飞舞，到处游走<br>五（舞蹈病）环（环形红斑）星（心脏炎）光（多关节炎）下（皮下小结）游走性一多发性                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                 |
|     |      |                                 |

类风湿性关节炎

## 2026 陶老师 500 考点预测 (331-334) --- 类风湿热临床表现

|                           |         |                                  |
|---------------------------|---------|----------------------------------|
| 发病与 IgM 直接关系，是滑膜组织发生的慢性炎症 |         |                                  |
| 关节症状                      | 晨僵      | 约 95% 病人有晨僵的程度和持续时间可作为判断病情活动度的指标 |
|                           | 关节疼痛和肿胀 | 最早出现，最常见部位为腕、掌指关节，多呈对称性、持续性      |
|                           | 畸形及功能障碍 | 呈天鹅颈、纽扣花样畸形多见于较晚期病人              |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (335-336) --- SLE 临床表现

|                |                                                                         |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 皮肤黏膜损害         | 80%病人有，暴露部位出现对称的皮疹，典型者在双面颊和鼻梁部有深红色或紫红色蝶形红斑                              | 典型：蝶形红斑     |
| 关节与肌肉疼痛        | 90%受累及，关节肿痛是首发症状，受累的关节常是近端指间关节、腕、足部、膝和踝关节。肌痛见于 50%的病人，有时出现肌炎，但很少引起肌肉萎缩。 | 对称分布，较少引起畸形 |
| 肾脏损害           | 几乎所有 SLE 病人均有不同程度肾脏损害，表现为肾小球肾炎或肾病综合征，一旦发展为尿毒症，则成为病人死亡的常见原因              |             |
| 【陶老师巧记】红太狼喜欢蝴蝶 |                                                                         |             |

系统性红斑狼疮皮肤损害的特点是蝶形红斑

【陶老师记忆】风火轮是环状

风湿热的典型特征是环形红斑



## 2026 陶老师 500 考点预测 (337-340) ---SLE 辅助检查

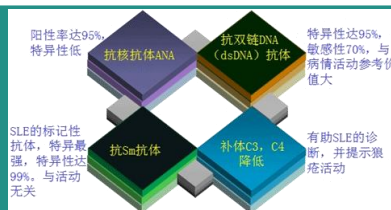
SLE 辅助检查

最佳筛选实验——抗核抗体 (ANA) ; 【陶老师巧记】筛子筛核桃

特异性最高——抗 Sm 抗体;

活动性最有价值——抗 dsDNA 抗体

【陶老师巧记】活动 (dong--dsDNA)



## 2026 陶老师 500 考点预测 (341) ---各种抗体知识点总结

【陶老师巧记】各种抗体知识点总结

(S) IgA: 爱自然、爱呼吸, 爱你的孩子就母乳喂养-呼吸系统

IgE: 一个爱吃酸菜的肥胖小男孩-哮喘

IgG: G-Guo-唯一可以通过胎盘的 G-Gan-肝硬化

IgM: M-美甲-甲肝 M-Mo-滑膜炎、类风湿

SLE--抗核抗体--系统性红斑狼疮



## 2026 陶老师 500 考点预测 (342) ---烧伤死因

急性体液渗出期  
(休克期)

是烧伤后 48 小时内导致病人死亡的主要原因

感染期

创面从渗出逐渐转化为吸收为主, 创面及组织中的毒素和坏死组织分解产物吸收入血, 引起中毒症状

## 2026 陶老师 500 考点预测 (343) ---烧伤深度



| 分度项目 | I 度 (红斑性)         | II 度 (水疱性)   |                  | III 度 (焦痂性)       |
|------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
|      |                   | 浅            | 深                |                   |
| 深度   | 表皮浅层              | 表皮生发层, 真皮乳头层 | 皮肤真皮层            | 全皮层, 甚至皮下、肌肉骨骼    |
| 水泡   | 无                 | 大小不一水泡, 以大为  | 小水泡              | 无                 |
| 创面   | 红斑状、干燥, 轻度红肿, 无感染 | 创面红润, 潮湿红肿明显 | 创面微湿, 红白相间, 水肿明显 | 焦黄、炭化、焦痂, 树枝状栓塞血管 |

【陶老师巧记】

1. 烧伤深度范围 I 度--浅--表皮浅层--I 度最浅

浅 II 度--生发层、真皮乳头层 深 II 度--真皮层

2. 你真肤浅, 只看重我的身材 (两个 XX) 和长发



## 3. 你伤我伤得真（真皮层）深（深Ⅱ度） III度--全皮层

## 2026 陶老师 500 考点预测（344）---有机磷农药中毒临床表现

有机磷中毒=接触史+大蒜味+肌颤动+瞳孔针尖样瞳孔+肺部湿啰音+胆碱酯酶活力降低。

|              |                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 毒蕈碱样<br>症状 M | 中毒后最早出现，平滑肌痉挛（过度兴奋）+腺体分泌增多。<br><b>表现：</b> 恶心+呕吐+腹痛+腹泻+ <b>瞳孔缩小</b> +多汗或大汗淋漓+心跳减慢+尿频+大小便失禁；支气管痉挛和分泌物增多→气急、肺部湿啰音， <b>严重者出现肺水肿</b> 。 |
| 烟碱样症<br>状 N  | <b>常先从眼睑、面、舌开始</b> ，逐步发展至四肢，全身肌肉抽搐，而后发生肌力减退和瘫痪。横纹肌兴奋表现为 <b>肌纤维、肌束震颤</b> →后期转为抑制→ <b>肌无力，呼衰</b> 。                                  |

## 【陶老师巧记】

**毒蕈碱样症状（M 样症状）**记忆成：吃了毒蘑菇的表现：口吐白沫、大小便失禁、要死不活

**烟碱样症状（N 样症状）**记忆成：抽烟后的表现：兴奋不已啊！肌肉收缩

## 【陶老师巧记】

啊！这个做小三的女人，心眼真小，一不开心就喝农药，胆子真大，喝得口吐白沫，四肢抽搐

**陶老师解释：**心眼真小：瞳孔缩小 胆子真大：农药中毒机制和胆碱酯酶有关，胆子越大越好

**M 样症状**—口吐白沫 分泌物增多 **N 样症状**—肌肉收缩 **啊**—阿托品治疗



## 2026 陶老师 500 考点预测（345）---不同疾病的气味

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不同疾<br>病的<br>气<br>味 | ① <b>烂苹果</b> →酮症酸中毒；② <b>大蒜味</b> →有机磷中毒；③ <b>苦杏仁</b> →氰化物中毒；④ <b>氨味/尿味</b> →尿毒症；⑤ <b>肝臭味</b> →肝性脑病；⑥ <b>恶臭味痰</b> →支扩、肺脓肿；⑦ <b>酸腐宿食</b> →幽门梗阻；⑧ <b>粪臭味呕吐</b> →低位肠梗阻 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2026 陶老师 500 考点预测（346）---各种中毒的区别

|                         |                                                                                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 各种<br>中毒<br>的<br>区<br>别 | <b>一氧化碳中毒</b> →口唇樱桃红色<br><b>阿托品中毒</b> →瞳孔扩大、神志模糊、抽搐、昏迷<br><b>有机磷农药中毒</b> →呼气大蒜味，针尖样瞳孔<br><b>乙醇中毒</b> →先兴奋后抑制，瞳孔散大，饮酒史 | <b>吗啡中毒</b> →呼吸抑制，昏迷，瞳孔缩小<br><b>氰化物中毒</b> →苦杏仁味<br><b>酮症酸中毒</b> →呼吸深大，呼气烂苹果味<br><b>洋地黄中毒</b> →心律失常、黄视、绿视 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2026 陶老师 500 考点预测（347）---瞳孔异常常见疾病

|                  |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瞳孔异<br>常常见<br>疾病 | <b>双瞳孔散大</b> :视神经萎缩、濒死状态、阿托品中毒、深昏迷<br><b>双侧瞳孔缩小</b> :有机磷中毒、氯丙嗪中毒、吗啡中毒<br><b>双侧瞳孔不等大</b> :颅内病变<br><b>瞳孔对光反射消失</b> :危重、深昏迷 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2026 陶老师 500 考点预测（348）---阿托品化与阿托品中毒

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 阿托品化 | ①瞳孔较前扩大，对光反应存在；②颜面潮红，各种腺体分泌减少，皮肤干燥，口干， |
|------|----------------------------------------|

|                                                                                                              |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | 痰少，肺部啰音减少或消失；③心率加快；④意识障碍减轻                                      |
| 阿托品中毒                                                                                                        | 瞳孔极度散大、高热 $>40^{\circ}\text{C}$ 、谵妄，躁动，幻觉，双手抓空、昏迷、心动过速，甚至有室颤发生。 |
| <b>【陶老师巧记】</b><br>阿托品化记忆成喝酒后的表现或者男人看到美女后的表现<br>眼睛睁大，颜面潮红、口干舌燥所以要吞口水、心跳加快、容易被迷惑<br>阿托品中毒就是喝酒喝醉后的表现：神志不清、抽搐、昏迷 |                                                                 |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (349) ---中暑的分类

| 类型            | 特点                              | 表现                                                  |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 热衰竭<br>(中暑衰竭) | 最常见，多由于大量出汗→失水、失钠→血容量不足→周围循环衰竭  | 头痛+头晕+口渴+血压↓+晕厥或意识模糊+体温正常                           |
| 热痉挛<br>(中暑痉挛) | 大量出汗后口渴而饮水过多，盐分补充不足→血中钠、氯↓→肌肉痉挛 | 腓肠肌痉挛最为多见，体温多正常                                     |
| 热射病<br>(中暑高热) | 高热、无汗、意识障碍“三联征”为典型表现            | 体温 $>40^{\circ}\text{C}$ +皮肤干热，无汗+谵妄和昏迷+抽搐+脉搏加快+BP↓ |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (350) ---破伤风临床表现



治疗的关键：控制和解除痉挛，预防窒息。



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

**【陶老师巧记】** 说人家伤风败俗的时候 咬牙切齿 --咀嚼肌

## 2026 陶老师 500 考点预测 (351) ---破伤风治疗

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 清除毒素来源  | 彻底清创 (预防破伤风最关键的措施)，用 3%过氧化氢冲洗，敞开伤口 |
| 中和游离毒素  | 尽早注射破伤风抗毒素 (预防破伤风最有效、最可靠的方法)       |
| 控制并解除痉挛 | 治疗的重要环节                            |
| 防治并发症   | 保持呼吸道通畅，给予支持疗法和应用抗生素，首选的抗生素是青霉素    |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (352) ---骨折早期并发症

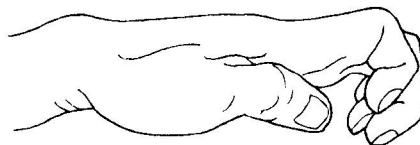
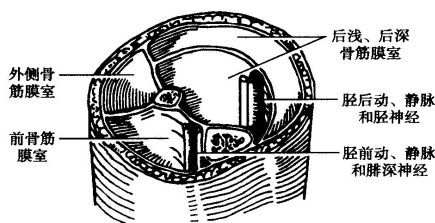
|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 骨筋膜室综合征 | 骨筋膜室内压力增高，使软组织血液循环障碍，肌肉、神经急性缺血而出现的一系列早期综合征，常见于前臂和小腿骨折，主要表现为肢体剧痛、肿胀、指(趾)呈屈曲状、活动受限、 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

局部肤色苍白或发绀，常由骨折血肿、组织水肿或石膏管过紧引起。

脂肪栓塞

骨折端血肿张力大，骨髓腔内脂肪微粒通过破裂的静脉窦进入血循环，可引起肺、脑血管栓塞，病情危急甚至突然死亡



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (353) ---骨折后神经损伤

### 【陶老师巧记】

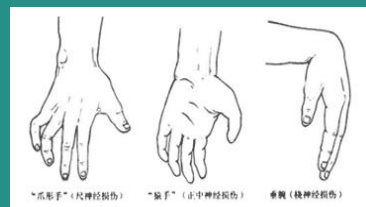
手部神经损伤手势：中原垂桡吃鸡爪(正中-猿手，桡-垂腕，尺-爪形手)

手部神经损伤感觉障碍：尺小指，桡虎口，正中中指

(1)迟早(爪)--尺神经损伤：爪形手

(2)中原--正中神经损伤：猿手

(3)闹炊烟--桡神经损伤：垂腕



## 2026 陶老师 500 考点预测 (354) ---颅底骨折



| 骨折部位 | 瘀斑部位           | 脑脊液漏   | 脑神经损伤                                             |
|------|----------------|--------|---------------------------------------------------|
| 颅前窝  | 熊猫眼征           | 鼻漏     | 嗅神经、视神经 (I II)                                    |
| 颅中窝  | 乳突区 (Battle 征) | 耳、鼻漏   | 面神经、听神经 (VII VIII) 【陶老师巧记】七面 (面神经) 玲珑，二听 (听神经) 八方 |
| 颅后窝  | 耳后及枕下部、咽后壁     | 枕下部脑脊液 | 第IX~XII对脑神经                                       |

颅底骨折的诊断主要依靠临床表现来确定

颅前窝骨折：熊猫眼征(眼眶发育)+鼻漏=颅前窝骨折

颅中窝骨折：有个 Battle 征所以颅中窝骨折就会出现耳漏

颅后窝骨折：耳后及枕下部、咽后壁

【陶老师巧记】：颅前窝-熊猫眼 你前一天晚上熬夜看书，第二天就成熊猫眼了

颅中窝-耳、鼻漏 耳朵在中间 所以颅中窝有耳漏 【陶老师巧记】中耳炎



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (355) ---传染病分类

|    |                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲类 | 鼠疫和霍乱                                                                                                                                                                |
| 乙类 | 非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、人感染 H7N9 禽流感、脊髓灰质炎、肺炭疽---按照甲类传染病管理、麻风病、病毒性肝炎、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。 |
| 丙类 | 流行性感冒(含甲型 H1N1 型流感)、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行                                                                                                                        |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病，除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病、**手足口病**、红眼病。

### 【陶老师巧记】

1. 甲类传染病：鼠疫、霍乱（2 小时内直报）

【陶老师巧记】：**家里（甲类）的老鼠（鼠疫）到处乱（霍乱）窜**

2. 属于乙类传染病按照甲类管理的是：非典型肺炎、禽流感、脊髓灰质炎、肺炭疽

【陶老师巧记】：**飞禽走兽烧成了灰终于安家了：飞（非典、肺炭疽）禽（禽流感）灰（脊髓灰质炎）安家（按照甲类管理甲型流感）**

（陶老师特别提醒：禽流感、脊髓灰质炎作为第二梯队）

3. 丙类：【陶老师巧记】：**一黑（胡须）一红（口红）来一口，两风两虫三流行**

**黑热病，红眼病，手足口病，风疹，麻风，包虫，丝虫（无弓形虫）**流感，流行性腮腺炎，流行性或地方性斑疹伤寒

4. 乙类：只记甲类和丙类，其余的乙类



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（356-360）---各种皮疹鉴别表格记忆汇总

|        | 麻疹                                | 水痘                  | 猩红热                                          |
|--------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 病原体    | 麻疹病毒                              | 水痘-带状疱疹             | 乙型溶血性链球菌                                     |
| 特性     | Koplik 斑                          | 四世同堂：斑疹、丘疹、疱疹、结痂疹   | 杨梅舌帕氏线<br>口周苍白圈                              |
| 皮疹特点   | 初见于耳后发际，自头面部—颈—躯干—四肢，热退后色素沉着及细小脱屑 | 头面—躯干—四肢，末端稀少，呈向心分布 | 皮肤弥漫性充血，上面有密集针尖样的大小皮疹，全身皮肤均可受累               |
| 发热特点   | 发热 3-4 天后出疹，出疹期为发热的高峰期            | -----               | 发热 1-2 天出疹，出疹时高热                             |
| 并发症    | 肺炎                                | 皮肤感染                |                                              |
| 隔离时间   | 出疹后 5 天                           | 全部结痂                | 咽试子 3 次阴性                                    |
| 保护易感人群 | 隔离观察 21 天                         | 隔离观察 21 天           | <b>隔离观察 7 天【陶老师巧记】</b><br><b>猩——一个星期 7 天</b> |

### 陶老师护理巧记法总结：

1. 麻疹、房间隔缺损、室间隔缺损的主要并发症均是肺炎

2. 出疹期 多在发热 3~4 天后出现皮疹，出疹时体温最高，持续 3~4 天。

3. 麻疹的出疹顺序：先见于耳后、发际，渐及额部、面部、颈部，然后自上而下延至躯干和四肢，最后达手掌和足底，一般 3 日出齐。

【陶老师巧记】麻疹出疹顺序记忆--麻--吗--？（像个问号）

### 【陶老师巧记】

斑疹--丘疹--水疱疹---结痂疹，由于演变快，各种疹可同时出现，皮肤有痒感水痘抓破后容易感染（最常见的并发症：皮肤感染）

【陶老师巧记】大水向（向心性肥胖）东流啊，一场大水（水痘）冲走了四世同堂（出疹特点）一大家族，经常泡在水里、皮肤受不了（感染）啊——水痘禁用阿司匹林



**陶老师护理巧记法：猩红热**

猩--大猩猩的嘴巴--口周苍白圈--天上的星星 很多很密集 --针尖大小

红--红的舌头--草莓舌 杨梅舌，青红皂白--青霉素--和小红青梅竹马谈恋爱（链球菌感染）

热--大猩猩很怕热-- 帕氏线

**2026 陶老师 500 考点预测（361-369）---对各种隔离的总结记忆**

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 呼吸道隔离 | 肺结核、百日咳、流脑等                                       |
| 消化道隔离 | 伤寒、甲型肝炎、细菌性痢疾等。肠道隔离等                              |
| 血液隔离  | 直接或间接接触血液和体液传播，艾滋病、梅毒、乙肝等                         |
| 昆虫隔离  | 疟疾，乙型脑炎、出血热、斑疹伤寒、回归热等                             |
| 接触隔离  | 接触分泌物传染：破伤风、气性坏疽、腮腺炎等                             |
| 严密隔离  | 具有严重传染性：鼠疫、霍乱、新型冠状病毒肺炎、非典、甲流、高致病性禽流感、脊髓灰质炎、肺炭疽等   |
| 保护性隔离 | 适用于抵抗力低下或极易感染的病人，如：早产儿、严重烧伤、白血病、脏器移植、免疫缺乏（艾滋病晚期）等 |

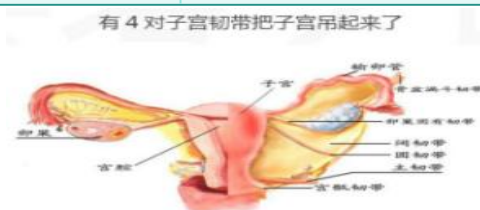
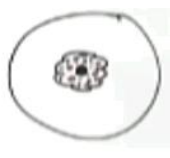


扫码获取陶老师

免费题库、免费视频

**2026 陶老师 500 考点预测（370-373）---子宫韧带**

|      | 解剖特点                            | 功能                 | 【陶老师巧记】             |
|------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| 圆韧带  | 起源于两侧子宫角，往前下终止于大阴唇的前端           | 维持子宫前倾位置           | “一圆钱，一角钱”           |
| 阔韧带  | 里面有丰富的血管、神经、淋巴管，为疏松组织，终止于两侧的骨盆壁 | 维持子宫左右固定位，限制子宫两侧倾斜 | 阔老板，左拥右抱，自己在中间      |
| 主韧带  | 横行于宫颈两侧和骨盆侧壁之间                  | 固定宫颈位置、防止子宫下垂      | 下地狱后，在那里大叫“主啊，救救我吧” |
| 宫骶韧带 | 向后向上牵引宫颈                        | 维持子宫前倾位置           |                     |

**2026 陶老师 500 考点预测（374-375）---妊娠期母体变化**

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 循环系统的变化 | <p>1. 心脏 妊娠后期因膈肌升高，心脏向左、上、前方移位，心跳和心浊音界也跟着移动，可以听到 I-II 级柔和的吹风样杂音（正常现象），心脏容量至妊娠末期约增加 10%，心率于妊娠晚期休息时每分钟增加 10~15 次（两个人的血液循环）</p> <p>2. 心排出量 心排出量自妊娠 10 周逐渐增加，至妊娠 32~34 周达高峰（孕妇心衰的高发期）。临产后在第二产程心排出量显著增加。产后 3 天也是心排出量增加的高峰（压力减低，回心血量增多）</p> |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 血液系统的变化

1. 血容量：循环血容量于妊娠 6~8 周开始增加，至妊娠 **32~34 周达高峰**，增加 30%~45%，平均增加 **1450ml**，维持此水平直至分娩。

2. 凝血因子：妊娠期血液处于高凝状态，对预防产后出血有利。

【陶老师巧记】10 15 32 34 40 45 1450 血液稀释高凝抗感染



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (376--379) ---中晚期妊娠的诊断

| 妊娠周数         | 手测宫底高度       | 尺寸耻上子宫长度 (cm)  |
|--------------|--------------|----------------|
| 12 周末        | 耻骨联合上 2-3 横指 |                |
| 16 周末        | 脐耻之间         |                |
| 20 周末 (5 个月) | 脐下 1 横指      | 18 (15.3-21.4) |
| 24 周末 (6 个月) | 脐上 1 横指      | 24 (22.0-25.1) |
| 28 周末        | 脐上 3 横指      | 26 (22.4-29.0) |
| 32 周末        | 脐与剑突之间       | 29 (25.3-32.0) |
| 36 周末 (9 个月) | 剑突下 2 横指     | 32 (29.8-34.5) |
| 40 周末        | 脐与剑突之间或略高    | 33 (30.0-35.3) |



【陶老师巧记】用节日简单记忆：三八妇女节 五一下地劳动 六一儿童节 喝酒舞剑

陶老师解释：三一脐上 3 横指 八一孕 28 周 五一五个月-孕 20 周 一下一脐下 1 横指

六一六个月-孕 24 周 一一脐上 1 横指 酒一9 个月一剑：剑突

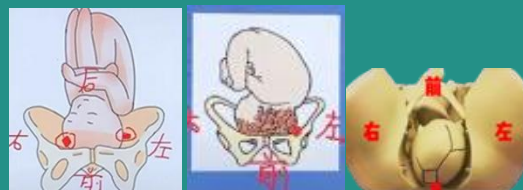
【陶老师巧记总结重要考点——胎方位的判断】

第一步：标出母体骨盆的前后左右；

第二步：找出胎儿先露部及指示点（考题一般考头先露）

枕先露以枕骨——找后囟 臀先露以骶骨 肩先露以肩胛骨

第三步：判断指示点在母体骨盆的方位——画十字



## 2026 陶老师 500 考点预测 (380-384) ---妊娠期护理

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 胎动        | 18~20 周出现（和胎心出现时间一样）。正常频率 3-5 次/时，若缺氧早期胎动加快，后期变慢           |
| 胎心音       | 妊娠 18~20 周用听诊器经孕妇腹壁能听到胎儿心音，每分钟 <b>110~160 次</b> 。能确诊妊娠且为活胎 |
| 仰卧位低血压综合征 | 此时若改为 <b>左侧卧位</b> ，使下腔静脉血流通畅，血压迅即恢复正常                      |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (385-387) ---产力

|                     |     |                                                                                          |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子宫收缩力<br>(主要产力、贯穿分) | 节律性 | 临产开始时， <b>宫缩间歇期 5~6 分钟，持续约 30 秒</b> 。<br>宫口开全 (10cm) 后， <b>宫缩间歇期仅 1~2 分钟，持续时间 60 秒</b> 。 |
|                     | 对称性 | 正常宫缩起自两侧宫角部，以微波形式向宫底中线集中，左右对称                                                            |
|                     | 极性  | 宫缩以宫底部最强最持久，向下逐渐减弱、变短，宫底部收缩力的强度几乎是子宫下段的 2 倍。此为子宫收缩力的极性                                   |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

|                  |                                                              |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 娩全过程)            | 缩复作用                                                         | 子宫体部肌纤维缩短变宽, 间歇时肌纤维重新松弛, 但不能完全恢复到原来长度 |
| 腹壁肌、膈肌收缩力 (统称腹压) | 第二产程时娩出胎儿的 <b>重要辅助力量</b> , 腹压在第二产程末期配合宫缩时运用最有效。              |                                       |
| 肛提肌收缩力 (第二三产程)   | 有协助胎先露在骨盆腔进行 <b>内旋转的作用</b> 。胎头枕部露于耻骨弓下时, 能协助胎头 <b>仰伸</b> 及娩出 |                                       |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (388-389) ---产程分期

|    | 第一产程                                                                  | 第二产程                              | 第三产程                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 别称 | 宫颈扩张期                                                                 | 胎儿娩出期                             | 胎盘娩出期                        |
| 定义 | 从规律宫缩开始至宫口开全 ( <b>宫颈只能容纳一个手指头</b> ) 至宫口开全 ( <b>10cm</b> ), 分为潜伏期和活跃期。 | 从宫口开全至胎儿娩出                        | 从胎儿娩出至胎盘娩出                   |
| 时间 | 初产妇潜伏期一般不超过 <b>20h</b> , 经产妇不超过 <b>14h</b>                            | 一般初产妇最长 <b>不超过 3h</b> , 经产妇不超过 2h | 需 5~15 分钟, 不应超过 <b>30 分钟</b> |

## 第一产程妇女的观察

|      | 潜伏期                        | 活跃期         |
|------|----------------------------|-------------|
| 临床表现 | 从临产出现规律宫缩至宫口扩张 6cm (0-6cm) | 宫口扩张 6~10cm |
| 时间   | <b>最大时限 20 小时</b>          |             |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (390-394) ---产程曲线异常



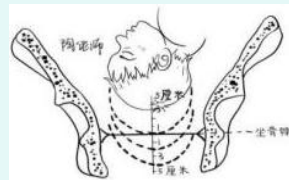
扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 潜伏期延长  | 初产妇>20 小时, 经产妇>14 小时称潜伏期延长                                       |
| 活跃期延长  | 活跃期宫颈口扩张速度<0.5cm/h 称活跃期延长                                        |
| 活跃期停滞  | 当破膜且宫颈口扩张≥6cm 后, 若宫缩正常, 宫颈口停止扩张≥4 小时; 若宫缩欠佳, 宫颈口停止扩张≥6 小时称为活跃期停滞 |
| 第二产程延长 | 初产妇超过 3 小时、经产妇超过 2 小时(硬膜外麻醉镇痛分娩时初产妇>4 小时, 经产妇>3 小时) 产程无进展        |
| 第二产程停滞 | 第二产程达 1 小时胎头下降无进展                                                |
| 胎头下降延缓 | 活跃期晚期及第二产程, 初产妇胎头下降速度初产妇<1.0cm/h, 经产妇<2.0cm/h                    |
| 胎头下降停滞 | 活跃期晚期胎头停留在原处不下降 1 小时以上                                           |
| 滞产     | 总产程超过 24h                                                        |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (395-399) ---异常产程处理

|        | 协调性宫缩乏力         | 不协调性宫缩乏力               |
|--------|-----------------|------------------------|
| 原因     | 头盆不称、胎位异常→多为继发性 | 初产妇年龄过大、过小→多为原发        |
| 特点     | 宫缩持续时间短、间歇时间长   | 极性倒置, 子宫下段持续性收缩        |
| 对母儿的影响 | 宫腔内压力低, 对母儿影响小  | 宫腔内压力高, 易发生窘迫          |
| 临床表现   | 宫缩高峰手压宫底有凹陷     | 持续性下腹痛, 拒按, 胎位不清, 产妇烦躁 |

|        |                                                                                                                                  |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 对产程的影响 | 活跃期和第二产程延长                                                                                                                       | 潜伏期延长                                                          |
| 处理     | 产道、胎儿都正常，增强子宫收缩<br>①肥皂水灌肠—宫口 $<6\text{cm}$<br>②人工破膜：宫口 $\geq 6\text{cm}$ 、胎膜未破<br>③缩宫素：宫口 $\geq 6\text{cm}$ 、胎膜已破<br>④胎儿宫内窘迫—剖宫产 | 协调宫缩，恢复正常极性<br>①哌替啶：100mg;<br>②吗啡：10~15mg;<br>③地西泮<br>④未纠正→剖宫产 |



胎头颅骨最低点平坐骨棘平时，以“0”表达；坐骨棘以上为“-”；坐骨棘以下为“+”。  
棘上1cm为“-1”，棘下1cm为“+1”，以此类推

$S>+3/4$ 、宫口已开全——有问题——助产

$S<+3/4$ 、宫口未开全——有问题——剖

【陶老师巧记】——协调性子宫收缩乏力处理方法

记忆成情人节抓小三的场景，给2个小三灌肠，打三和泼墨（破膜）泼墨后缩宫素 缺氧立即剖宫

|                    |          |                               |
|--------------------|----------|-------------------------------|
| 第二产程（胎儿娩出期）有三种处理方法 | 缩宫素静脉滴注  | 用于宫缩减弱，乏力                     |
|                    | 产钳助产     | 胎头位于坐骨棘以下（ $S\geq +3$ ）时，就用产钳 |
|                    | 剖宫产      | 头盆不称、未入盆应（ $S=1、2$ ）时及时行剖宫产术  |
|                    | 不协调性宫缩乏力 | 给予哌替啶（杜冷丁）                    |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（400-404）——胎心音听诊部位

|       |                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 腹部检查  | <p>（1）视诊：注意腹形及大小，腹部有无妊娠纹、手术瘢痕和水肿。</p> <p>（2）触诊：四步触诊法检查子宫大小、胎产式、胎先露、胎方位及先露是否衔接。</p> <p>（3）听诊：胎心音在靠近胎背侧上方的孕妇腹壁上听得最清楚。</p> <p>枕先露时，胎心音在脐下方右或左侧；臀先露时，胎心音在脐上方右或左侧</p> <p>肩先露时，胎心音在脐部下方听得最清楚</p> |
| 绘制妊娠图 | 将各项检查结果如血压、体重、宫高、腹围、胎位、胎心率等填于妊娠图中，绘成曲线图，观察动态变化                                                                                                                                             |



### 胎心音听诊部位总结

胎背上方听得最清楚（因为胎儿是卷曲着的）

枕左前→孕妇脐的左下方最清楚

骶右前→孕妇脐的右上方最清楚

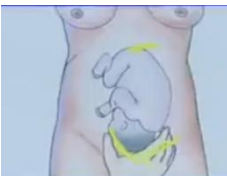
横位→孕妇脐附近最清楚

【陶老师巧记】头在下→在下听，头在上→在上听 右在右听，左在左听，横位中间听（因为心脏靠近）



## 2026 陶老师 500 考点预测（405）——四步触诊法

第一步摸头尾，第二步摸两侧，第三步定先露，第四步站头部。



## 2026 陶老师 500 考点预测 (406-409) ---流产类型

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 先兆流产 | 子宫大小与停经周数相符，宫口未开，少量阴道流血。<br>【陶老师巧记】有想法，但是还没有做，有这个预兆                              |
| 难免流产 | 宫口开了，晚期可见胚胎组织或胎囊堵塞于宫口内，东西还没有出来，所以子宫大小与停经周数相符或略小。【陶老师巧记】不得不                       |
| 不全流产 | 宫颈口已扩张，妊娠物排出了一部分，还有一部分留在里面，所以子宫小于停经周数。容易引起大出血及感染（部分内容物卡在宫口，容易导致）。【陶老师巧记】一半在里一半在外 |
| 完全流产 | 妊娠物已全部排出，子宫接近正常大小，宫颈口已关闭。【陶老师巧记】（相当于生完孩子一样）                                      |

流产临床类型的鉴别

| 类型   | 先兆流产  | 难免流产     | 不全流产    | 完全流产     |
|------|-------|----------|---------|----------|
| 宫口   | 闭     | 扩张       | 扩张或组织堵塞 | 闭        |
| 子宫大小 | 与孕周相符 | 与孕周相符或略小 | 小于孕周    | 正常或略小于孕周 |
| 处理   | 可保胎   | 尽早刮宫     | 立即刮宫    | 不必处理     |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (410-413) ---妊娠期高血压临床表现及分类

| 分类                                    | 诊断依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 妊娠期高血压                                | 血压：BP $\geq$ 140/90mmHg，妊娠期首次出现，并于产后 12 周恢复正常<br>尿蛋白：(-)；症状：患者可伴有上腹部不适或血小板减少，产后方可确诊。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 子痫前期                                  | 轻度 血压：BP $\geq$ 140/90mmHg，孕 20 周以后出现；尿蛋白： $\geq$ 300mg/24h 或随机尿蛋白(+)；<br>症状：可伴有上腹不适、头痛等症状。<br>重度 血压：BP $\geq$ 160/110mmHg；尿蛋白： $\geq$ 2.0g/24h 或(++) / (+++)<br>症状：持续性头痛或其他脑神经或视觉障碍；持续性上腹不适。血肌酐 $>106\mu\text{mol/L}$ ；<br>血小板 $<100\times 10^9/\text{L}$ ；微血管病性溶血（血 LDH 升高）；血清 ALT 或 AST 升高。<br>【陶老师巧记】小三为重，三级高血压，重度子痫前期 |
| 子痫                                    | 子痫前期孕妇抽搐不能用其他原因解释                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 休息                                    | 保证充足的睡眠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 解痉                                    | 首选硫酸镁，但是硫酸镁容易中毒，所以只要在治疗过程中出现膝反射减弱或消失，就提示为硫酸镁中毒。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 利尿药物                                  | 脑水肿首选甘露醇，肺水肿首选速尿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 降压                                    | 首选肼屈嗪（屈膝）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 【陶老师巧记】看到美丽的姑娘，就走不动路了，我中了你的毒，就这样被你屈服。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (414-415) ---前置胎盘、胎盘早剥

## 【陶老师巧记口诀】前置胎盘重要考点:

前置胎盘: “二无一反复阴道流血”; “一无”: 无诱因→晨起/深夜睡眠时; “二无”: 无痛→无宫缩→子宫软→胎心胎位清; “反复”: 多次出血, 故不超过平时的月经量, 如超过→警戒性出血

“阴道流血”: 外出血, 与失血性休克的症状成正比

【陶老师巧记】前无古人后无来者——前: 前置胎盘 无: 无痛性阴道流血

## 2026 陶老师 500 考点预测 (416-419) ---产后出血病人的护理

胎儿娩出后 24 小时内阴道分娩者失血量 $\geq 500\text{ml}$ , 剖宫产 $\geq 1000\text{ml}$  称产后出血。产后出血在我国是产妇首位死亡原因。

| 分类     | 常见原因                                             | 处理原则                                            |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 宫缩乏力   | 是产后出血最常见原因, 常见诱因: 产程延长、子宫过度膨胀 (如多胎妊娠、巨大儿、羊水过多) 等 | 加强宫缩是最有效的止血方法, 按摩子宫、缩宫素。                        |
| 胎盘因素   | 胎盘部分剥离、胎盘剥离后滞留、胎盘嵌顿、胎盘粘连、胎盘植入等                   | 若胎盘已剥离: 立即取出胎盘; 若剥离困难、疑有胎盘植入: 切忌强行剥离, 以手术切除子宫为宜 |
| 软产道裂伤  | 会阴、阴道、宫颈等部位裂伤                                    | 彻底止血, 按解剖层次逐层缝合裂伤                               |
| 凝血功能障碍 | 妊娠合并重症肝炎、死胎等                                     | 补充凝血因子                                          |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (420-422) ---生命发展各期特点

| 分期   | 时间                                         | 各期生理特点                                                                    |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 围生期  | 怀孕 7 个月到出生后, 7 天这段时间为围生期                   | 这个时间小儿开始接触外界, 所以这个时期小儿的发病率, 死亡率是最高的, 次选新生儿期                               |
| 新生儿期 | 从胎儿娩出至 28 天此期包含在婴儿期内                       | 小儿的发病率, 死亡率亦很高, 仅次于围生期                                                    |
| 婴儿期  | 从出生至 1 岁之前                                 | 儿童两个发育高峰→婴儿期 (最快)、青春期                                                     |
| 幼儿期  | 从 1 岁至满 3 岁前                               | 自主性和独立性表现不断发展, 意外伤害发生率高。                                                  |
| 学龄前期 | 从 3 岁后至 6~7 岁小学前                           | 智力发育非常快, 关键阶段                                                             |
| 青春期  | 女孩从 11~12 岁至 17~18 岁; 男孩从 13~14 岁至 18~20 岁 | 女孩青春期开始和结束较男孩早 2 年左右, 体格生长发育再次加速, 生殖系统加速发育并渐趋成熟, 该期以成熟的认知能力和自我认同感的建立为显著特征 |

扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (423-426) ---过渡期食物添加

| 月龄     | 添加辅食                          |
|--------|-------------------------------|
| 1~3 个月 | 汁状食物: 菜汤、水果汁、肝油和钙剂            |
| 4~6 个月 | 泥状食物: 含铁配方米粉、配方奶、蛋黄、菜泥、水果泥    |
| 7~9 个月 | 末状食物: 粥、烂面、饼干、烤馒头片、全蛋、鱼、肝泥、肉末 |

看书做题 1 天, 不如听课 1 小时

10~12 个月 **碎**状食物：稠粥、软饭、面条、馒头、面包、豆制品、碎肉、带馅食品

【陶老师巧记】支离破碎（汁泥破碎）

## 2026 陶老师 500 考点预测（427）---预防免疫接种

【陶老师巧记】

出生乙肝卡介苗。0, 1, 6 打乙肝。2, 3, 4 是吃糖丸。3, 4, 5 百白破。八月莫忘麻疹苗。

【陶老师巧记】

出生乙肝卡介苗 2、3、4 月脊髓苗 3、4、5 月百白破

百白破三联针，三月开始连续打三个月。（记忆：333）



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测（428--432）---新生儿的特殊生理状态

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生理性<br>体重下降 | 新生儿在生后由于体内水分丢失较多、胎粪排出等。出现体重下降，但一般不超过 10%，生后 10 日左右，恢复到出生时的体重<br>【陶老师巧记】重点记忆两个都是 10—由 10 想到食物的“食”音相似，所以人不吃食物就会瘦，体重就会下降  |
| 生理性黄疸       | 大部分新生儿在生后 2~3 日即出现黄疸，4~5 日最重，足月儿最迟 2 周内，早产儿可延迟到 3~4 周消退                                                                |
| 乳腺肿大        | 母体的孕酮和催乳素经胎盘至胎儿体内，出生后激素影响突然中断所致。出生后 3~5 日，乳腺触到蚕豆到鸽蛋大小肿块，多于 2~3 周消退。不需处理。<br>【陶老师巧记】大的乳腺才能做小三—出生后 3-5 天出现，2-3 周消退；都有“3” |
| 假月经         | 母体雌激素在孕期进入胎儿体内，出生后突然消失引起。部分女婴在生后 5~7 日，可见阴道流出少量的血液，持续 1 周。一般不需处理。                                                      |
| “马牙”        | 上皮细胞堆积或黏液腺分泌物积留。新生儿上颌中线和齿龈上常有黄白色小斑点，民间称“马牙”，又称“上皮珠”，生后数周自然消失，不需处理。                                                     |



## 2026 陶老师 500 考点预测（433）---Apgar 评分

| 体征               | 出生后一分钟内的评分标准 |          |         |
|------------------|--------------|----------|---------|
|                  | 0 分          | 1 分      | 2 分     |
| 心跳次数 (P)         | <80          | <100     | ≥100    |
| 呼吸 (R)           | 无            | 呼吸浅表，哭声弱 | 呼吸佳，哭声响 |
| 肌张力 (g)          | 松弛（伸展）       | 四肢屈曲     | 四肢活动好   |
| 弹足底或导管插鼻刺激反应 (g) | 无反应          | 有些动作，如皱眉 | 反应好     |
| 皮肤颜色 (P)         | 全身青紫或白       | 躯干红，四肢紫  | 全身红     |

8~10 分为正常新生儿，4-7 分为轻度窒息，0-3 分为重度窒息

【陶老师巧记】小三为重症是妻（7）解释：（小于 3 分是重度窒息，7 分以下是轻度窒息）

## 2026 陶老师 500 考点预测 (434) ---新生儿黄疸特点

| 特点                                | 生理性黄疸                                                                          | 病理性黄疸                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 出现时间                              | 足月儿 2~3 天; 早产儿 3~5 天                                                           | 出现的早, 常在生后 24h 内出现黄疸                                                           |
| 高峰时间                              | 足月儿 4~5d 达高峰; 早产儿 5~7d 达高峰                                                     |                                                                                |
| 血清胆红素程度                           | 足月儿 <221 $\mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl)<br>早产儿 <257 $\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl) | 足月儿 >221 $\mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl)<br>早产儿 >257 $\mu\text{mol/L}$ (15mg/dl) |
| 每日胆红素升高                           | <85 $\mu\text{mol/L}$ (5mg/dl) 或每小时上升 <8.5 $\mu\text{mol/L}$ (0.5mg/dl)        | >85 $\mu\text{mol/L}$ (5mg/dl) 或每小时 >8.5 $\mu\text{mol/L}$ (0.5mg/dl)          |
| 病理性黄疸的特点总结: 出现早、持续久、升得快、程度重、退而复现。 |                                                                                |                                                                                |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (435) ---食管癌

|      |                                                                             |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 病理   | 好发部位: <b>食管胸中段</b> 组织学类型: <b>90%为鳞癌 其次为腺癌</b> 主要转移途径: <b>淋巴转移</b>           |  |
| 临床表现 | 早期症状: 偶有咽下 <b>食物哽噎感</b> 中、晚期典型症状: <b>进行性吞咽困难</b>                            |                                                                                     |
| 普查筛选 | 带网气囊食管脱落细胞学检查 (拉网检查) <b>【陶老师巧记】筛子筛核桃</b><br><b>筛子: 密密麻麻的 像网一样, 看到筛子就想到网</b> |                                                                                     |
| 确诊方法 | 食管纤维内镜检查 + 病理检查                                                             |                                                                                     |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (436) ---进行性考点总结

**【陶老师进行性考点总结】**

进行性**意识障碍**: 小脑幕切迹疝      进行性**吞咽困难**: 食管癌  
 进行性**呼吸困难**: ARDS                  进行性**黄疸加重**: 胰腺癌  
 进行性**排尿困难**: 前列腺增生          进行性**痛经加重**: 子宫内膜异位症



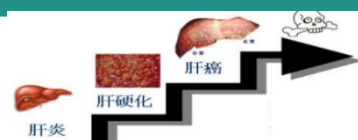
扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (437) ---肠道手术 饮食护理

**【肠道手术 饮食护理考点总结】** 术后拔除胃管进食: 术后肠蠕动恢复后可拔除胃管

第 1 日可少量饮水或米汤;      第 2 日半量流食, 每次 50~80ml;  
 第 3 日进全量流食, 每次 100~150ml, 以蛋汤、菜汤、藕粉为宜;  
 第 4 日可进半流质饮食, 如稀饭; 第 10~14 日可进软食。注意少量多次, 开始时每日 5-6 餐, 以后逐渐减少进餐次数并增加每次进餐量, 逐步恢复正常饮食。

## 2026 陶老师 500 考点预测 (438) ---肝癌病人的护理



|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 病因     | 与病毒性肝炎 (以乙型肝炎为主)、肝硬化、黄曲霉菌等因素相关                                    |
| 病理生理   | 典型演变过程: 急性肝炎→慢性肝炎→肝硬化→肝癌我国以肝细胞性肝癌为主要类型                            |
| 主要转移部位 | <b>肝内转移 (最多)</b> 和肝外转移, <b>肝外转移包括血行转移 (多到肺)</b> , 淋巴转移 (肝门), 种植转移 |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (439) ---胰腺癌

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 临床表现 | 最常见首发症状：上腹痛和上腹饱胀不适<br>胰头癌最主要症状/体征：黄疸（进行性加重，伴瘙痒、陶土便） |
| 辅助检查 | 肿瘤标志物：CA19-9（临床重要指标） 可靠检查方法：CT                      |



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (440) ---宫颈癌 子宫内膜癌

人乳头瘤病毒（HPV）感染是宫颈癌发生的主要危险因素。

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 接触性阴道出血 | 早期表现为同房后出血或双合诊检查后出血，以后可出现月经间期出血或绝经后出血，晚期出血量可增多，甚至癌肿破坏大血管造成大出血——宫颈癌 |
| 阴道流血    | 绝经后出现阴道流血为典型症状——子宫内膜癌                                              |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (441-445) ---侵蚀性葡萄胎

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 病史    | 侵蚀性葡萄胎大多继发于良性葡萄胎，病人均有葡萄胎病史，多发生在葡萄胎清除术后 6 个月以内，最常见是 2 月左右                    |
| 阴道出血  | 是侵蚀性葡萄胎最常见的症状。多发生在葡萄胎后，阴道不规则出血。合并有阴道转移结节破溃时可发生反复大出血                         |
| 转移灶表现 | 侵蚀性葡萄胎最常见的转移部位是肺，其次是阴道、宫旁，脑转移较少见。出现肺转移时，病人往往有咯血                             |
| 辅助检查  | ①血和尿的绒毛膜促性腺激素（hCG）测定。②胸部 X 线摄片：判断是否发生肺转移<br>③超声波检查。“落雪状”“蜂窝状” ④组织学诊断。       |
| 治疗原则  | 化疗为主，手术和放疗为辅。年轻未生育者可保留子宫，需手术治疗者主张先化疗，待病情稳定后再行手术。转移病人的护理 肺转移                 |
| 严密随访  | 出院后严密随访，警惕复发。第 1 年每月随访 1 次，1 年后每 3 个月随访 1 次，持续至 3 年后改为每年 1 次至 5 年。随访内容同葡萄胎。 |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (446) ---绒毛膜癌

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 绒毛膜癌 | 高度恶性滋养细胞肿瘤，早期即可血行转移至全身，引起出血坏死<br>常见转移部位依次为：肺、阴道、脑及肝 病理特点：绒毛结构消失 |
|------|-----------------------------------------------------------------|

## 2026 陶老师 500 考点预测 (447) ---乳腺癌

|        |                                                                                                                                                               |     |                                      |       |                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 乳房肿块   | 乳房的外上象限，早期表现是患侧乳房出现无痛、单发的小肿块；其次在乳晕区和内上象限。肿块质硬，表面不光滑，边缘不整齐，与周围组织分界不清；                                                                                          |     |                                      |       |                                         |
| 乳房外形改变 | <table> <tr> <td>酒窝征</td><td>癌块侵犯连接腺体与皮肤的 Cooper 韧带，使之收缩，导致皮肤表面凹陷</td></tr> <tr> <td>橘皮样改变</td><td>癌肿继续增大淋巴管被癌细胞堵塞时，可出现皮肤淋巴水肿，在毛囊处形成许多点状凹陷</td></tr> </table> | 酒窝征 | 癌块侵犯连接腺体与皮肤的 Cooper 韧带，使之收缩，导致皮肤表面凹陷 | 橘皮样改变 | 癌肿继续增大淋巴管被癌细胞堵塞时，可出现皮肤淋巴水肿，在毛囊处形成许多点状凹陷 |
| 酒窝征    | 癌块侵犯连接腺体与皮肤的 Cooper 韧带，使之收缩，导致皮肤表面凹陷                                                                                                                          |     |                                      |       |                                         |
| 橘皮样改变  | 癌肿继续增大淋巴管被癌细胞堵塞时，可出现皮肤淋巴水肿，在毛囊处形成许多点状凹陷                                                                                                                       |     |                                      |       |                                         |

转移征象

淋巴结转移

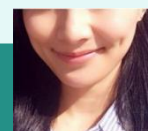
多见于同侧腋窝

血行转移

移及肺、肝、骨等远处转移症状

【陶老师巧记】侵犯连接腺体与皮肤的 Cooper 韧带——“酒窝征”——0-0

淋巴管被癌细胞堵塞时——橘皮样——桔林



## 2026 陶老师 500 考点预测 (448) --- 乳腺疾病

乳腺炎：金黄色葡萄球菌感染，乳房红肿热痛

乳腺癌：无痛单发肿块，好发外上象限，“橘皮样”改变，“酒窝征”

乳腺囊性增生：周期性疼痛

乳腺纤维腺瘤：单个肿块，边界清楚，表面光滑，增长缓慢

乳管内乳头瘤：边界清楚，有乳头溢液

扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (449) --- 肿瘤标记物

【陶老师总结】

肝癌:AFP 肠癌:CEA 前列腺癌:PSA 侵蚀性葡萄胎:HCG 胰腺癌:CA19-9 卵巢癌:CA125

## 2026 陶老师 500 考点预测 (450-458) --- 肿瘤常见疾病【辅助确诊检查】

【肿瘤常见疾病（辅助确诊检查）】

1. 分化型甲状腺癌:细针穿刺细胞学检查。
2. 肺癌:首选、普查: X 线 毛刺征 简单有效早期诊断: 痰脱落细胞检查  
中央型: 纤维支气管镜 周围型: 经皮肺穿刺活检
3. 食管癌:带网气囊食管脱落细胞学检查是一种简便易行的普查筛选; 诊断方法: 食管纤维内镜能在直视下观察病变形态, 并可钳取活组织作病理学检查。
4. 胃癌:纤维胃镜确诊。
5. 原发性肝癌:超声检查—首选; 肝穿刺活组织检查—病理诊断检查
6. 大肠癌:内镜检查诊断最有效、可靠。
7. 肾癌:腹部超声:最简便、常用方法。

【肿瘤常见疾病（辅助确诊检查）】

8. 膀胱癌:膀胱镜检查诊断最直接、重要的方法。
9. 前列腺癌:前列腺穿刺检查确诊。
10. 子宫颈癌:宫颈刮片细胞学检查—宫颈癌筛查的主要方法  
宫颈和宫颈管活体组织检查—确定宫颈癌前病变和宫颈癌的最可靠方法
11. 乳腺癌:X 线钼靶摄片和干板照相检查—对区别乳房肿块性质有一定的价值, 可用于乳癌的普查; 活组织病理检查可确诊。
12. 子宫内膜癌:分段诊断性刮宫—诊断子宫内膜癌最可靠的方法
13. 胆囊癌:腹部超声引导下细针穿刺抽吸活检, 可帮助明确诊断
14. 胆管癌:首选腹部超声检查

## 2026 陶老师 500 考点预测 (459) --- 脑部损伤疾病的区别

## 【脑部损伤疾病的区别】

脑震荡：逆行性遗忘, 神经系统无阳性体征

脑挫裂伤：意识障碍

硬脑膜外血肿：中间清醒期

硬脑膜下血肿：最常见，较早出现颅内压↑，脑疝

脑内血肿：进行性加重的意识障碍

蛛网膜下腔出血：首选 CT, 先天性脑动脉瘤(病因)，头痛、脑膜刺激征阳性



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (460) --- 格拉斯哥昏迷计分

| 睁眼反应 | 计分 | 言语反应 | 计分 | 运动反应 | 计分 |
|------|----|------|----|------|----|
| 自动睁眼 | 4  | 回答正确 | 5  | 遵嘱活动 | 6  |
| 呼唤睁眼 | 3  | 回答错误 | 4  | 刺痛定位 | 5  |
| 刺痛睁眼 | 2  | 吐词不清 | 3  | 躲避刺痛 | 4  |
| 不能睁眼 | 1  | 有音无声 | 2  | 刺痛肢屈 | 3  |
|      |    | 不能发声 | 1  | 刺痛肢伸 | 2  |
|      |    |      |    | 不能活动 | 1  |

## 【陶老师巧记】

主动正确活动为满分

不能为 1 分，躲避刺痛为 4 分，伸开双手为 2 分

呼唤睁眼，胡言乱语，刺痛肢屈 3 分

【陶老师巧记】：被出轨了很委屈，只能偷偷的胡思乱想，呼唤小三的名字

【陶老师格拉斯哥昏迷计分 (GCS) 巧记】

1. 睁眼反应：主动呼喊你痛不？4-3-2-1

2. 言语反应：我是对的，错了就得死，小三胡言乱语，一不做二不休，干掉她

3. 运动反应：666 动起来 5 好痛，使劲躲，小三委屈，伸个懒腰

## 2026 陶老师 500 考点预测 (461--465) --- 卧位总结

## 【陶老师总结】

**被迫卧位**：患者意识清晰，有变换卧位的能力，由于疾病的影响或治疗的需要而采取的卧位，支气管哮喘急性发作被迫采取端坐位

**被动卧位**：自身无力变换卧位，见于昏迷、极度衰弱、瘫痪的患者

**主动卧位**：病人自主采取的卧位，健康人或者病情比较轻的病人

**端坐卧位**：急性肺水肿、心包积液、支气管哮喘急性发作时的病人，因极度呼吸困难而被迫端坐。

**俯卧位**：腰、背、臀部检查，配合胰胆管造影等。

**【陶老师总结】**

右侧卧位只有两个:新生儿哺乳后、阿米巴痢疾灌肠  
其余都是左侧卧位  
截石位:妇科检查,分娩 中凹卧位:休克  
膝胸卧位:矫正胎位、法洛四联症  
头低足高位:大咯血窒息、胎膜早破、空气栓塞  
头高足低位:开颅术后、颅内压增高、颅骨牵引  
患侧卧位:咯血 健侧卧位:肺段、肺叶切除术后  
1/4 侧卧位:一侧全肺切除术后 去枕平卧位:全麻术后未清醒

**2026 陶老师 500 考点预测 (466) ---尿失禁****【陶老师总结】**

**真性:**又称完全性,膀胱颈和尿道括约肌受损  
**压力性:**腹内压增高突增时,尿液不自主的流出  
**急迫性:**严重尿频、尿急而膀胱不受意识控制而发生尿液排空  
**充溢性:**又称假性,膀胱过度充盈,压力增高而引起尿液不断溢出



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

**2026 陶老师 500 考点预测 (467) ---输血反应****【陶老师总结】**

**过敏反应:**荨麻疹、喉头水肿  
**发热反应:**发冷、寒战,继而体温升高;反应轻者,减慢滴数可使症状减轻,严重者停止输血  
**溶血反应:**腰背部剧烈疼痛、黄疸、血红蛋白尿、急性肾衰竭  
**枸橼酸钠中毒反应:**手足抽搐、出血倾向、血压下降、心率缓慢

**2026 陶老师 500 考点预测 (468) ---皮损区别****【陶老师总结】**

系统性红斑狼疮:蝶形红斑 风湿热:环形红斑 伤寒:玫瑰疹  
水痘:丘疹、斑疹、疱疹、结痂疹(四世同堂)

**2026 陶老师 500 考点预测 (469) ---关节脱位区分****【陶老师总结】**

肩关节脱位:“方肩”畸形,杜加试验阳性  
肘关节脱位:肘后三点关系失常  
髋关节脱位:患肢出现典型的屈曲、内收、内旋、短缩畸形  
股骨颈骨折:屈曲、内收、外旋、缩短

## 2026 陶老师 500 考点预测 (470--475) --- 首选治疗

## 【陶老师总结】

1. 心房颤动急性期应首选同步电复律。同房非同室。
2. 心室颤动首选非同步直流电除颤。
3. 肠套叠首选治疗方法为空气灌肠。
4. 葡萄胎清宫术后避孕首选方法为阴茎套。
5. 侵蚀性葡萄胎首选化疗。
6. 早期肺癌首选手术治疗。
7. 休克型肺炎治疗首先应注意补充血容量；体位首选中凹卧位。
8. 产后子宫收缩乏力首选治疗方法为按摩子宫和应用缩宫素。
9. 肝癌首选和最有效的方法仍是手术治疗。
10. 治疗宫颈癌的首选方法是手术，适于 Ia — IIa 期的患者。
11. 哺乳期妇女首选工具避孕，如：阴茎套



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (476--480) --- 典型表现

## 【陶老师总结】

1. 硬脑膜外血肿典型的意识障碍是伤后昏迷有“中间清醒期”。
2. 左心衰最典型的临床表现是阵发性夜间呼吸困难。
3. 急性肺水肿的典型表现为咳粉红色泡沫样痰。
4. 心绞痛典型的特点是阵发性胸痛或心前区不适。
5. 主动脉瓣狭窄典型的三联症是劳力性呼吸困难、心绞痛、晕厥。
6. 纤维蛋白性心包炎的典型体征是心包摩擦音
7. 下肢静脉曲张最典型表现为下肢可见迂曲扩张静脉团。
8. 胃溃疡的疼痛典型节律为进食-疼痛-缓解。
9. 十二指肠溃疡病人疼痛典型节律为进食-缓解-疼痛。
10. 溃疡性结肠炎最主要症状是腹泻，典型者呈黏液脓血便。
11. 金黄色葡萄球菌肠炎典型大便为暗绿色。
12. 急性阑尾炎典型表现为转移性右下腹痛。
13. 典型的腹外疝由疝环、疝囊、疝内容物和疝外被盖组成。
14. 胆管炎的典型症状：急腹痛、寒战高热 和黄疸，称为 Charcot 三联症。
15. 急性梗阻性化脓性胆管炎的典型表现为腹痛、寒战高热、黄疸、休克和昏迷。
16. 肠扭转时可见典型的鸟嘴征，肠套叠时可见杯口征。
17. 肺炎链球菌肺炎典型表现起病多急骤，高热、寒战，呈稽留热型。  
典型者在发病 2-3 天咯铁锈色痰。
18. 支气管扩张典型表现：慢性咳嗽和大量脓性痰；反复咳血；反复肺部感染。
19. 支气管扩张 X 线检查典型可见不规则的蜂窝状透亮阴影或沿支气管的卷发状阴影。
20. 典型肺气肿体征为：桶状胸、语颤减弱、叩诊过清音、听诊呼吸音减弱、呼气延长。
21. 支气管哮喘典型表现为反复发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难。

22. 流行性感胃典型的临床症状是：急起高热、全身疼痛、显著乏力和轻度呼吸道症状。
23. 结核性脑膜炎的典型改变是糖和氯化物均降低。
24. 急性肾小球肾炎典型表现为水肿、血尿、高血压及肾功能受累。
25. 膀胱结石的典型症状：排尿突然中断、改变体位尿可继续排出。
26. 前列腺增生典型的表现是进行性排尿困难。
27. 滴虫阴道炎典型白带是稀薄泡沫样。
28. 外阴阴道假丝酵母菌病典型白带是凝乳、豆渣样。
29. 细菌性阴道炎典型匀质、稀薄、灰白色阴道分泌物，可有臭味或鱼腥味。
30. 老年性阴道炎典型白带是稀薄黄色脓性或血性。
31. 精神分裂症紧张型的典型表现是紧张性木僵和紧张性兴奋两种状态。
32. 狂犬病典型者见水、饮水、听水声甚至仅提及饮水时，均可以引起严重咽喉肌痉挛。
33. 热射病典型表现为高热、无汗、意识障碍“三联征”。
34. 气管、支气管异物的一个典型症状是阵发性、痉挛性咳嗽。

## 2026 陶老师 500 考点预测 (481--485) ---数值考点

### 【陶老师总结】

1. 肝硬化腹水每天进水量应限制在 1000ml 以内
2. 高度水肿每天进水量应限制在 1000ml 以内
3. 慢性肾衰每天进水量应限制在 1500ml 以内
4. 颅内压增高每天输液量 1500-2000ml
5. 肾结石大量饮水每天进水量>3000ml
6. 尿路感染大量饮水每天进水量>2500ml
7. 当引流量(每小时 100-200ml)应考虑为活动性出血
8. 颅内压的正常值 70-200mmH<sub>2</sub>O (儿童:50-100mmH<sub>2</sub>O)
9. 胸腔穿刺抽液每次抽液量不超过 1000ml
10. 等渗盐水不超过 500ml, 尿量不少于 600ml
11. 穿刺放羊水一次不超过 1500ml
12. 每次放胸腔引流液不超过 1000ml
13. 使用利尿剂不宜过快, 每天体重减轻不超过 0.5kg 为宜
14. 急性肾衰竭少尿期的补液原则是每日进水量为一天液体总排出量加 500ml 估算: 进液量=尿量+500ml
15. 肝硬化限制盐在 1~2g/天
16. 连续使用约束带每 2 小时松解一次
17. 风湿性心脏病每天食盐摄入量不超过 6g
18. 急性肾小球肾炎急性期 1~2 周内, 钠的摄入, 每日 1~2g 水肿消退后每日 3~5g
19. 肾病综合征盐<3g/天, 蛋白质 1g/(kg 天)
20. 慢性肾衰盐<2g, 低蛋白:20-40g/天
21. 肾小球肾炎:蛋白尿 1-3g/天
22. 低白血症:血浆白蛋白<30g/L
23. 胰腺炎病人禁食时每天的液体入量常需达 3000ml



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

24. 胸腔闭式引流拔管指征 24h 引流量 $<50\text{ml}$ , 脓液 $<10\text{ml}$
25. T 管引流出胆汁色泽正常, 且引流量逐渐减少, 可在术后 14 日拔管
26. 开放性损伤: 争取 6-8 小时内清创, 2 小时内注射破伤风抗毒素
27. 正常尿量  $1500\text{ml}$
28. 多尿 $>2500\text{ml}$
29. 少尿 $<400\text{ml}$  或每小时 $<17\text{ml}$  【陶老师巧记: 皇家四少】
30. 尿闭 $<100\text{ml}$  或 12 小时内无尿
31. 留 24 小时尿: 尿蛋白 尿糖 肌酐
32. 留 12 小时尿: 艾迪计数
33. 尿培养: 中段尿 导管尿膀胱穿刺尿



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (486) ---数值考点-热型

### 【陶老师总结】

- . 稽留热: 体温持续升高达  $39\sim 40^{\circ}\text{C}$ , 24 小时波动范围不超过  $1^{\circ}\text{C}$ , 常见于伤寒, 肺炎链球菌肺炎等
- . 弛张热: 体温在  $39^{\circ}\text{C}$  以上, 24 小时体温差达  $1^{\circ}\text{C}$  以上, 常见于败血症, 风湿热, 化脓性疾病等
- . 间歇热: 高热与正常体温交替出现, 发热时体温骤升达  $39^{\circ}\text{C}$  以上, 常见于疟疾, 急性肾盂肾炎等
- . 速脉: 成人脉率超过 100 次/min
- . 缓脉: 成人脉率低于 60 次/min
- . 呼吸过速: 成人超过 24 次/min
- . 呼吸过缓: 成人低于 10 次/min

## 2026 陶老师 500 考点预测 (487) ---数值考点

### 【陶老师总结】

- 正常成人脉率:  $60-100$  次/min
- 正常成人呼吸频率:  $16-20$  次/min
- 正常收缩压:  $90-139\text{mmHg}$
- 舒张压:  $60-89\text{mmHg}$
- 脉压差:  $30-40\text{mmHg}$
- 等渗性脱水血钠:  $130-150\text{mmol/L}$
- 低渗性脱水血钠:  $<130\text{mmol/L}$
- 高渗性脱水血钠:  $\geq 150\text{mmol/L}$
- 低钾血症:  $<3.5\text{mmol/L}$
- 高钾血症:  $>5.5\text{mmol/L}$
- 体温 $>39^{\circ}\text{C}$ 应物理降温



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频

## 2026 陶老师 500 考点预测 (488-490) ---沟通类型分类

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 沟通符号分类 | <p><b>语言沟通</b>: 语言沟通是以语言文字为媒介的一种准确、有效、广泛的沟通形式。</p> <p><b>非语言沟通</b>: 是通过非语言媒介, 如表情、眼神、姿势、动作等类语言实现的沟通</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 沟通渠道分类 | <p><b>正式沟通</b>: 是指通过正式的组织程序, 按组织规定的线路和渠道进行的信息传递与交流的过程。一般适用于正式场合, 如护士向护士长汇报工作等。</p> <p><b>非正式沟通</b>: 是指通过正式沟通渠道以外的信息交流和意见沟通。这种沟通方式没有明确的规范和系统, 不受组织约束, 不受时间和场合限制, 没有固定的传播媒介。如朋友聚会、各种传闻、小道消息等。缺点是传递的信息不一定可靠, 容易失真。因此, 我们要对来自非正式沟通渠道信息的真实性进行甄别, 不要轻易相信。</p>                                                                        |
| 沟通流向分类 | <p><b>纵向沟通</b>: 是指组织或群体中上下级成员中的沟通, 分为上行沟通和下行沟通两种形式。①上行沟通: 即“下情上达”。具有非命令性、民主性、主动性和积极性等特点。②下行沟通: 即“上情下达”。例如上级对下级传达政策。具有指令性、法定性、权威性和强迫性等特点。</p> <p><b>横向沟通</b>: 是指在组织内部横向部门和人员间进行的沟通, 分为平行沟通和斜行沟通两种形式。①平行沟通: 在组织内部同一层次的人员之间进行的信息传递, 具有非命令性、协商性和双向性的特点。②斜行沟通: 在组织内部既不在同一条指挥链, 又不在同一层次的人员之间进行的信息传递。具有协商性和主动性的特点。</p>                |
| 沟通目的分类 | <p><b>征询型沟通</b>: 是指以获得期待的信息为目的的沟通。一般采取提问的方式进行。通过征询型沟通可以获得患者的既往史、家族史、遗传史, 这些信息的获得可以为护士明确护理诊断和制订护理计划提供可靠的依据。</p> <p><b>告知型沟通</b>: 是指以告知对方自己的意见为目的的沟通。可采用口语和书面语两种沟通方式。如医院环境、规章制度、护理计划、检查程序及注意事项等。</p> <p><b>说服型沟通</b>: 是指以改变对方态度为目的的沟通, 主要采用说理的方式进行。由于说服型沟通是以改变他人的观点、思想、情感、态度为目的说服患者采取有利于健康的行为方式。临床上常见的说服型沟通还有规劝、批评、调解和争议等形式。</p> |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (491) ---人际沟通的层次

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般性沟通 (一般交谈) | 属于沟通中的最低层次, 是指一般性社交应酬的开始语, 如“你好”“今天天气真好”“你吃饭了吗”“有空来家坐坐”之类的招呼语。如护士与患者第一次见面时的寒暄话, 在开始时使用有助于在短时间内打开局面和建立信任关系。                       |
| 事务性沟通 (陈述事实) | 是一种陈述客观事实的沟通, 沟通中不掺入个人意见、观点和情感, 也不牵扯人与人之间的关系。如护士在工作中运用这种沟通方式, 鼓励患者叙述病情以了解患者的情况, 但应注意, 在此层次上的沟通主要是让患者叙述, 护士最好不要用语言或非语言性行为影响患者的陈述。 |
| 分享性沟通 (交流看法) | 是一种除了沟通信息, 还交流个人的想法和判断的沟通, 是比陈述事实又高一层次的沟通。沟通者希望表达自己的想法及判断, 并与对方分享, 以达到相互理解的目的。如作为帮助者的护士, 在沟通中应注意不要流露嘲笑的表情, 以免影响患者的信任。            |
| 情感性沟通 (交流情感) | 是指沟通的双方除了分享对某一问题的看法及判断, 还会表达及分享彼此的感觉、情感和愿望的沟通。护士应做到坦率、真诚、热情和正确地理解患者。                                                             |
| 共鸣性沟通        | 是沟通的最高层次, 指沟通的双方达到了短暂的、完全一致的、高度和谐的感觉, 是沟通                                                                                        |

(沟通高峰) 交流希望达到的理想境界。只有相互之间非常了解的人才能达到共鸣性沟通。

## 2026 陶老师 500 考点预测 (492) --- 认知效应含义 (考试重点)

|        |                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 首因效应   | 亦称 <b>第一印象</b> ，是指人在与他人首次接触时，根据对方的仪表、风度、言语、举止等作出的综合性判断                                                                                                            |
| 近因效应   | 在人际交往过程中，人们往往会比较 <b>重视新的信息，而相对忽略陈旧的信息</b> 。在人际认知中，这种最近或最后获得的信息对总体印象产生最大影响的效应即为近因效应。                                                                               |
| 社会固定印象 | 亦称 <b>刻板印象</b> ，是指某个社会文化环境 <b>对某一社会群体所形成的固定而概括的看法</b> ，如社会的固定印象为商人精明、知识分子文质彬彬、女性温柔等便形成了社会刻板效应。                                                                    |
| 晕轮效应   | 亦称月晕效应或 <b>光环效应</b> 【陶老师巧记】： <b>爱屋及乌</b>                                                                                                                          |
| 先礼效应   | 指在人际交往过程中向对方提出批评意见或某种要求时，先用礼貌的语言行为起始，以便对方容易接受，从而达到自己的目的【陶老师巧记： <b>先礼后兵</b> 】                                                                                      |
| 免疫效应   | 指当一个人已经接受并相信某种观点后，便会对相反的观点产生一定的抵抗力，即具有一定的“免疫力”【陶老师巧记： <b>固执</b> 】                                                                                                 |
| 投射效应   | 是指将自己的特点归因到其他人身上的心理倾向。个体对他人形成印象时，总是愿意用自己的认知标准去衡量他人，将自己的感情、意志、特性等投射到他人身上并强加于他人的心理倾向，即 <b>以己度人</b> ，认为他人具有与自己相同的特性。成语“ <b>五十步笑百步</b> ”“ <b>以小人之心度君子之腹</b> ”都是这样的例子。 |

## 2026 陶老师 500 考点预测 (493) --- 护士与病人的基本模式

- ①主动-被动型：【陶老师巧记总结：**就是脑子不好使的**】  
 ②指导-合作型：【陶老师巧记总结：**病情相对较轻，神志清**】  
 ③共同参与型：【陶老师总结慢性病：**糖尿病、高血压**】



## 2026 陶老师 500 考点预测 (494) --- 帮助病人认识角色特征

|            |                                |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 帮助病人认识角色特征 | 帮助患者认识角色特征。患者角色的适应不良大致有 5 种类型： |                                                                                                        |
|            | 角色行为缺如                         | 即患者未能进入角色。虽然医生诊断为有病，但本人否认自己有病，根本没有或不愿意意识到自己是患者。【陶老师巧记： <b>缺心眼，有病，不治，不承认自己有病</b> 】                      |
|            | 角色冲突                           | 同一个体常常 <b>承担着多种社会角色</b> ，当患者并需要从其他角色转化为患者角色时，患者一时难以实现认识角色适应。【陶老师巧记： <b>好几个角色</b> 】                     |
|            | 角色行为减退                         | 已进入角色的患者，由于更强烈的情感需要，不顾病情而从事力所不及的活动，表现出对病、伤的考虑不充分或不够重视，而影响到疾病的治疗。【陶老师巧记： <b>有病，在治，没有治好就不治了</b> 】        |
|            | 角色行为强化                         | 由于依赖性加强和自信心减弱，患者对自己的能力表示怀疑，对承担原来的社会角色恐慌不安，安心于已适应的患者角色现状，或者自觉病情严重程度超过实际情况小病大养。【陶老师巧记： <b>没病非说自己有病</b> 】 |
|            | 角色行为异常                         | 患者受病痛折磨感到悲观、失望等不良心境的影响导致行为异常，如对医务人员的攻击性言行，病态固执、抑郁、厌世，以致 <b>自杀</b> 等。【陶老师巧记： <b>病人精神出现问题</b> 】          |

看书做题 1 天，不如听课 1 小时

应用商店搜索【陶老师】APP-30 万题目  
 点击右下角微信联系陶老师

## 2026 陶老师 500 考点预测 (495) --- 护理伦理基本原则

## 【陶老师巧记总结】

- ①有利原则：尽量做出有利于病人的最佳选择
- ②不伤害原则：尽量减少护士自身失误，对病人一点伤害都没有
- ③公正原则：会涉及到患者的身份，一般是两个身份的对比
- ④尊重原则：针对某一个人，没有身份的对比，在选择的时候会出现。

## 2026 陶老师 500 考点预测 (496) --- 医疗事故的分级

《医疗事故处理条例》第四条规定，根据对患者人身造成的损害程度，将医疗事故分为四级

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 一级医疗事故 | 造成病人死亡，重度残疾             |
| 二级医疗事故 | 造成病人中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍 |
| 三级医疗事故 | 造成病人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍 |
| 四级医疗事故 | 造成病人明显人身损害的其他后果         |

## 【陶老师巧记】

- 故意（一级）弄死（致死）你，不弄死也弄残，三生有幸只是轻伤
- |              |              |
|--------------|--------------|
| 一级：死亡或重残     | 二级：中残、严重功能障碍 |
| 三级：轻残、一般功能障碍 | 四级：明显人身损害    |



## 2026 陶老师 500 考点预测 (497--499) --- 医疗损害责任

2021 年 1 月 1 日《中华人民共和国民法典》实施

第一千二百一十八条规定：病人在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。

第一千二百一十九条规定：医务人员在诊疗活动中应当向病人说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向病人说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其书面同意；不能或者不宜向病人说明的，应当向病人的近亲属说明，并取得其明确同意。医务人员未尽到前款义务，造成病人损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。

第一千二百二十条规定：因抢救生命垂危的病人等紧急情况，不能取得病人或者其近亲属意见的，经医疗机构负责人或者授权的负责人批准，可以立即实施相应的医疗措施。

第一千二百二十一条规定：医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务，造成病人损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。

第一千二百二十二条规定：病人在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，推定医疗机构有过错：违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定；隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料；遗失、伪造、篡改或者销毁病历资料。

第一千二百二十三条规定：因药品、消毒产品、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液造成病人损害的，病人可以向药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。病人向医疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的药品上市许可持有人、生产者、血液提供机构追偿。

第一千二百二十四条规定：病人在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，医疗机构不承担赔偿

责任：病人或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗；医务人员在抢救生命垂危的病人等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务；限于当时的医疗水平难以诊疗。

第一千二百二十五条规定：医疗机构及其医务人员应当按照规定填写并妥善保管住院志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录等病历资料。病人要求查阅、复制前款规定的病历资料的，医疗机构应当及时提供。

第一千二百二十六条规定：医疗机构及其医务人员应当对病人的隐私和个人信息保密。泄露病人隐私和个人信息，或者未经病人同意公开其病历资料的，应当承担侵权责任。

第一千二百二十七条规定：医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施不必要的检查。

第一千二百二十八条规定：医疗机构及其医务人员的合法权益受法律保护。干扰医疗秩序，妨碍医务人员工作、生活，侵害医务人员合法权益的，应当依法承担法律责任。

## 2026 陶老师 500 考点预测（500）——护理工作模式

### 【陶老师巧记总结】

护理工作模式：

个案护理：1 对 1（ICU）危重症患者、大手术后需要特殊护理的患者

功能制护理：分工不同，流水作业，没有领导    小组护理：分组，有领导（组长）

责任制护理：1 对多，负责到底，以病人为中心



扫码获取陶老师  
免费题库、免费视频